ANÁLISIS DE CASO : MORTALIDAD MATERNA

Sharon Katherine Acuña - Ginecologa y Obstetra / Lider
Ximena Paola Vela - Med general / Hospitalaria del servicio Ginecología
Natalia Bohorquez -Med general / Hospitalaria del servicio Ginecologia
Angie Melisa Ruiz - Interna de ginecologia
Juana Maria Gonzalez - Interna de UCI

HABLEMOS DE ESTADISTICAS

Tabla 4. Análisis bivariado entre muerte materna y morbilidad materna extrema, Colombia, semana epidemiológica 19 2025

Grupos de edad	Casos MM	Casos MME	Chi 2	RR (IC 95 %)*
15 a 19 años	9	1622	0,93	1,10 (0,54 - 2,22)
20 a 24 años	13	2899	0,69	0,84 (0,45 - 1,55)
25 a 29 años	11	2913	0,31	0,68 (0,35 - 1,31)
30 a 34 años	13	2490	1,00	1,02 (0,55 - 1,89)
35 y más años	16	2115	0,11	1,64 (0,93 - 2,89)
Tipo de seguridad social	**Casos MM**	**Casos MME**	**Chi 2**	**RR (IC 95 %)**
Contributivo	16	4739	0,03	0,52 (0,29 - 0,92)
Subsidiado	46	6732	0,00	2,19 (1,24 - 3,87)
Pertenencia étnica	**Casos MM**	**Casos MME**	**Chi 2**	**RR (IC 95 %)**
Indígena	14	584	0,00	5,65 (3,13 - 10,20)
Afrocolombiano	3	406	0,76	1,46 (0,46 - 4,65)
Otros	45	11143	0,00	0,23 (0,13 - 0,41)
Área de residencia	**Casos MM**	**Casos MME**	**Chi 2**	**RR (IC 95 %)**
Cabecera municipal	40	9644	0,00	0,47 (0,28 - 0,79)
Centro poblado	5	724	0,66	1,38 (0,55 - 3,43)
Rural disperso	17	1773	0,00	2,19 (1,26 - 3,83)
Número de controles prenatales	**Casos MM**	**Casos MME**	**Chi 2**	**RR (IC 95 %)**
Sin control prenatal	30	1410	0,00	6,31 (3,84 - 10,35)
Entre 1 y 3 controles prenatales	8	1694	0,72	0,82 (0,39 - 1,72)
Cuatro o más controles prenatales	24	7967	0,00	0,24 (0,14 - 0,41)

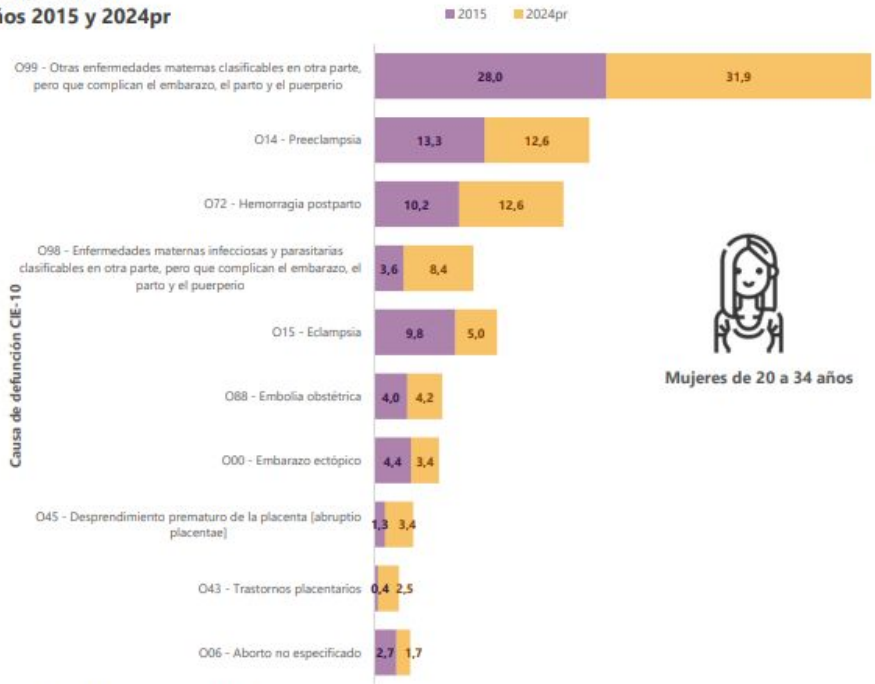
Fuente: numerador: Sivigila, Instituto Nacional de Salud 2024 - 2025 SE 19 cifras preliminares
*El grupo de referencia para el cálculo del riesgo relativo en las variables grupo de edad, pertenencia étnica, área de residencia y número de controles prenatales corresponde a la suma de todas las demás categorías diferentes a la categoría en análisis.

Tabla 3. Características sociales y demográficas de la mortalidad materna, Colombia, 2024 – 2025 semana epidemiológica 19

Edad de la madre	Histórico 2021 - 2024 SE 19	Acumulado de casos SE 19		Razón de mortalidad materna por 100 000 nacidos vivos	
		2024	2025	2024	2025
10 a 14 años	1	1	0	89,4	0,0
15 a 19 años	13	12	9	53,1	44,3
20 a 24 años	22	17	13	40,3	33,0
25 a 29 años	21	18	11	43,3	27,3
30 a 34 años	25	16	13	52,1	43,0
35 a 39 años	16	8	10	50,4	65,0
40 y más años	8	6	6	130,0	136,8
Tipo de afiliación en salud	**Histórico 2021 - 2024 SE 19**	**Acumulado de casos SE 19**		**Razón de mortalidad materna por 100 000 nacidos vivos**	
		2024	2025	2024	2025
Subsidiado	69	54	46	61,3	54,5
Contributivo	25	18	16	28,5	26,5
No afiliado	10	5	0	90,9	0,0
Área de residencia	**Histórico 2021 - 2024 SE 19**	**Acumulado de casos SE 19**		**Razón de mortalidad materna por 100 000 nacidos vivos**	
		2024	2025	2024	2025
Urbano	74	55	40	46,4	35,2
Rural	23	16	17	53,4	61,6
Pertenencia étnica	**Histórico 2021 - 2024 SE 19**	**Acumulado de casos SE 19**		**Razón de mortalidad materna por 100 000 nacidos vivos**	
		2024	2025	2024	2025
Indígena	15	16	14	197,1	185,8
Afrocolombiano	8	5	3	85,8	54,1
Otros	82	57	45	39,4	32,7

Fuente: numerador: Sivigila, Instituto Nacional de Salud 2024 - 2025 SE 19 cifras preliminares. Denominador: Nacidos vivos RUAF ND 2024 – 2025 datos preliminares.

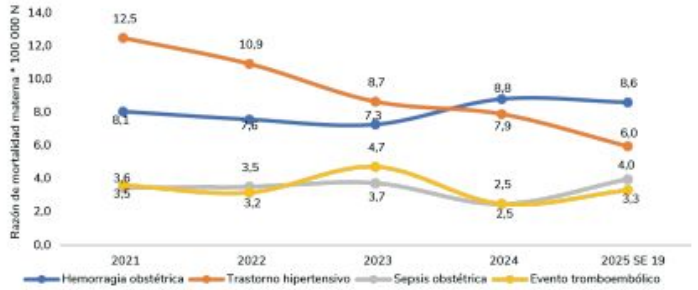
Gráfico 224. Primeras diez causas de muerte materna temprana en madres de 20 a 34 años
Total, nacional
Años 2015 y 2024pr



Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.
pr: cifras preliminares

comparadas con al año 2024 (figura 3).

Figura 3. Razón de las principales causas agrupada de muerte materna temprana, Colombia, 2020- 2024, semana epidemiológica 19 de 2025



Fuente: numerador: Instituto Nacional de Salud 2021 – 2024, SE 19 2025 cifras preliminares. Denominador: Nacidos vivos DANE 2021 a 2023, RUAF ND 2024 – 2025 datos preliminares

Caso x presentado 7/9/2025 - 12/9/2025
JLTC 1007307547



Se trata de paciente de 27 años G2P1V1 quien ingresa al servicio de urgencias el 7/9/2025 con gestación de 31+3 semanas, con antecedente de asma no tratado por cuadro clínico 1 día de evolución consistente en disnea de pequeños esfuerzo asociado a disfagia tos cianosante emetizante sin movilización de secreciones con antecedente de asma, en manejo con bromuro de ipratropio y betametasona sin mejoría de su cuadro

VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS

- Nacionalidad:colombiana
- estrato socioeconómico: 1
- EAPB coosalud regimen: subsidiado
- Residencia: vereda pueblo viejo - moniquira
- Estado civil: unión libre
- Escolaridad: bachiller
- vivía con: madre, hija de 10 meses y esposo en vereda - puente nacional
- Empleo : agricultura / galpones
- Circulo social: familia -manifestó durante todo su historial médico tener una buena red de apoyo
- Alimentación rica en carbohidratos
- Tenía dos gatos desde hace 5 años
- **prevención y promoción**
  vacunación:
- covid #1 dosis: astrazeneca previo a gestacion
- tétano en embarazo anterior: si *

ANTECEDENTES

- Patológicos: **asma, palpitaciones taquicardia sinusal pregestacional**
- Quirúrgicos: niega
- Farmacológicos: **aerovial inhalador: budesonida 200 mcg + formoterol 6 mg (capsulas inhalados), uso ocasional, calcio 1200 mg día**
- Alérgicos: niega
- Hospitalarios: niega
- Tóxico: niega consumo de sustancia psicoactivas, cigarrillo o licor
- Familiares: niega
- **Antecedente de preeclampsia madre o hermana : Madre con ant no claro de preeclampsia**
- historia de cáncer heredofamiliar niega
- transfusionales: niega
- **Hemoclasificación materna: o negativo**
- **¿requiere administración de inmunoglobulina anti d en semana 28? si *****
- traumáticos: niega
-

GINECOLOGICOS

- Menarquia: 12 años
- Ciclos: 30x5
- **Método anticonceptivo previo: implante subdérmico** FALLO**
- Planificación post parto: implante subdérmico
- ITS: niega
- Tamización de cáncer de cuello uterino: no recuerda

HISTORIA OBSTETRICA

- no historia de parto instrumentado
- no historia de macrosomía fetal
- madre con hipertensión gestacional, no claro
- **Embarazo previo : fup: 03/11/2024**
  peso al nacer: 3150 gr- talla : 50 cm- edad gestacional: 38 semanas
  complicaciones: ninguna
  lugar de atención: HRM
- embarazo actual planeado (no) deseado (si) aceptado (si) fallo método anticonceptivo (si)
- primipaternidad: no

Curso de enfermedad antes de la gestación actual

2022

Se registran dos consultas en donde la paciente manifestó, dificultad para respirar, dolor torácico y tos seca persistente

2023

Primera gestacion

Parto vaginal sin complicación del 6/7/2023

**Paciente con exámenes de pyp dentro de límites normales, por antc no claso recibió prevención primaria asa y calcio, En semana 34 con IMC 40, recibió tromboprofilaxis.

**Presentó un episodio de tos,seca disnea y dolor toracico 3/3/2023

PNF : Implante subdermico

2025

19/3/2025 atención en urgencias por cuadro respiratorio : diane y tos cianosante

** manejo sintomático y egreso

****9/4/2025 c**onsulta con prueba de embarazo positiva refiere S**IBILANCIAS RESPIRATORIAS CON DISNEA GRADO 4 SEGÚN ESCALA MRC, TOS SECA Y DOLOR TORÁCICO. USA BUDESONIDA/FORMOTEROL con mala respuesta - 11/4/2025 *** ingresa a control prenatal**

HISTORIAL CLÍNICO - GESTACIÓN ACTUAL

- PRIMERA CONSULTA: 2/08/2025 10:36 PM
- PRUEBA DE EMBARAZO POSITIVA: 09/04/2025
- FECHA DE ÚLTIMA REGLA REFERIDA: 27/01/2025
- FECHA PROBABLE DE PARTO: 03/11/2025
- CPN : 4
- FUE VALORADA POR PSICOLOGIA, ODONTOLOGIA NUTRICIÓN



EXÁMENES PYP DE CONTROL PRENATAL

PARACLÍNICOS PRIMER TRIMESTRE 21/04/2025

TOXO IGM NO REACTIVO, TOXO IGG NO REACTIVO, RUBEOLA IGG REACTIVO, GLICEMIA 77.1, CMV
IGG REACTIVO, TSH 0.55, RUBEOLA IGM NO REACTIVO, CMV IGM NO REACTIVO, VIH NEGATIVO, TREPONEMA
NEGATIVO, CHAGAS NEGATIVO, AS VHB NEGATIVO, FFV VAGINITIS INESPECÍFICA, COOMBS NEGATIVO,
HEMOCLASIFICACIÓN O NEGATIVO, HEMOGRAMA WBC 5950 N 76% L 17.8% HB 15.1 HCT 45.3 PLAQUETAS 294.000,
UROCULTIVO NEGATIVO
02/05/2025 GRAM NO SE OBSERVAN BACTERIAS, FFV INFECCIÓN MIXTA (METRONIDAZOL OVULOS 3/7), GRAM: NO
SE OBSERVAN BACTERIAS, UROANÁLISIS NORMAL, HEMOGRAMA WBC 6030 N 71% L 21.6% HB 15.4 HCT 49.6
PLAQUETAS 324.000

PARACLINICOS SEGUNDO TRIMESTRE

18/07/2025 TOXOPLASMA IGM NEGATIVO.
15/08/2025 TPO MENOR 0.8 CURVA DE TOLERANCIA AYUNAS 74.4 NO TOLERADA TOXOPLASMA IGM 0.04 NO
REACTIVO T4L 1.29 T3L2.49 TOXOPLASMA IGM 0.04 NO REACTIVO TREPONEMA NEGATIVO, VIH NO REACTIVO
HEMOGRAMA LEUCOS 91500 HB 17 HTO 55.7 PLAQ 316.000

ECOGRAFÍAS

26/04/2025 TRANSLUCENCIA NUCAL EMBARAZO INTRAUTERINO DE 12.2 SEMANAS, BAJO RIESGO PARA CROMOSOMOPATÍAS, BIENESTAR FETAL CONSERVADO, DOPPLER DE ARTERIAS UTERINAS NORMAL

02/05/2025 EMBARAZO DE 13.1 SEMANAS POR LCC

20/06/2025 DETALLE ANATÓMICA EMBARAZO DE 20.1 SEMANAS, CRECIMIENTO FETAL EN PERCENTIL 12, ESTUDIO LIMITADO POR PANÍCULO ADIPOSO, SIN MALFORMACIONES MAYORES. DOPPLER ARTERIAS UTERINAS NEGATIVO.

30/06/2025 CERVICOMETRÍA LONGITUD CERVICAL 35 MM, NORMAL PARA LA EDAD GESTACIONAL.

CONTROLES PRENATALES



11/4/2025

Embarazo d**e 10.4 por FUR a**ntecedente de disnea de esfuerzo a lo que asocia dolor torácico y tos seca, niega expectoración asociada a fiebre, en manejo con aerovial inhalador una vez al día en la mañana + jarabe **desde hace 20 días con lo que no ha evidenciado MEJORÍA.**
SV: TA: 110/70 mmhg FC:74LPM FR:18 RPM T:36° SPO2: 95%

APORTA
01/04/2025 EKG: FC 105 LPM, RITMO SINUSAL, EJE NORMAL, ADECUADA PROGRESIÓN DE LA ONDA R, SIN SUPRA O INFRADESNIVEL DEL SEGMENTO ST- TAQUICARDIA SINUSAL

IDX:
G2P1V1
EMBARAZO DE 10.4 SEMANAS POR FUR
RIESGO OBSTÉTRICO ALTO
PERIODO INTERGENÉSICO PROLONGADO
RIESGO ISOINMUNIZACIÓN RH NEGATIVO
RIESGO TROMBOEMBÓLICO BAJO
RIESGO PSICOSOCIAL: BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO 0
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: SOBREPESO PARA EDAD GESTACIONAL ATHALA IMC 29.4
RIESGO DE DEPRESIÓN POSPARTO: BAJO
PLANIFICACIÓN FAMILIAR POST PARTO: IMPLANTE SUBDÉRMICO



FORMATO AMFE PARA RIESGOS
PROCESO Y SUBPROCESO GESTIÓN DE RIESGOS
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.
SERVICIO URGENCIAS TRIAGE OBSTETRICO

Código:
Versión

NOMBRE	JESSIKA LISETH TORRES CUADROS			FECHA	02/05/2025	HORA	8:58am
DOCUMENTO	1007307547			EDAD GESTACIONAL	13.2 SEMANAS		
PACIENTE POST PARTO	SI		NO	X	DIAS DE PUERPERIO		
MOTIVO DE CONSULTA	SANGRADO, CEFALEA						

SIGNOS VITALES

TENSION ARTERIAL	PAS 125	PAD 77	Ta la	14	TRIAGE	TRIAGE II		Tipo MEOWS	RIESGO BAJO Observación cada 4 horas llamado a enfermera	
			PESO	72.6						
SpO2		95%	FR	18						
FRECUENCIA CARDIACA FETAL			FC	102						
ESTADO DE CONCIENCIA	ALERTA	X	FIO2	Aire ambiente						
	NO ALERTA		TEMP	35.6					PUNTAJE:	1
NIVEL DOLOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				X						

TRIAGE Y ATENCIÓN INMEDIATA
SIGNOS VITALES ANORMALES

grado ingresa con IDX
ixta → Manejo con
o fetal



14/5/2025

EMBARAZO DE 14.6 SEMANAS POR ECOGRAFÍA, ASINTOMATICA,
TA: 124/76 MMHG FC: 70 LPM FR:18RPM T:36° SPO2:95%
IDX
G2P1V1
EMBARAZO DE 14.6 SEMANAS POR ECOGRAFÍA DE TAMIZAJE
RIESGO OBSTÉTRICO ALTO
RIESGO DE SEROCONVERSIÓN PARA TOXOPLASMA ***
PERIODO INTERGENÉSICO CORTO
RIESGO ISOINMUNIZACIÓN RH NEGATIVO (INMUNOGLOBULINA ANTI D SEMANA 28 *********)
RIESGO TROMBOEMBÓLICO BAJO
RIESGO PSICOSOCIAL: BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO 0
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: SOBREPESO PARA EDAD GESTACIONAL ATHALA IMC 29.4
PLANIFICACIÓN FAMILIAR POST PARTO: IMPLANTE SUBDÉRMICO

PLAN
SE DA SUPLEMENTACIÓN Y ORDENES DE EXÁMENES DETALLE



21/07/2025

EMBARAZO DE 24.4 SEMANAS POR ECOGRAFÍA DE TAMIZAJE, DOCUMENTAN EXACERBACIÓN DE TOS CRÓNICA CIANOSANTE IMC 30, NYHA III/IV , CON AUSENCIA DE SÍNTOMAS CONGESTIVOS
TAS: 124 TAD: 76 TAM: 9.200 F.C.: 101 F.R.: 19 T°: 36 SO2: 95 PERFUSION: <2
IDX:
G2P1V1
EMBARAZO DE 24.4 SEMANAS POR ECOGRAFÍA DE TAMIZAJE
ASMA SIN TRATAMIENTO
TAQUICARDIA SINUSAL PREGESTACIONAL ***
RIESGO OBSTÉTRICO ALTO
RIESGO DE SEROCONVERSIÓN PARA TOXOPLASMA *** IGM NEGATIVO MES DE JUNIO
RIESGO ISOINMUNIZACIÓN RH NEGATIVO O-
ANTE DE MADRE CON THAE
RIESGO TROMBOEMBÓLICO BAJO
RIESGO PSICOSOCIAL: BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: SOBRE PESO PARA EDAD GESTACIONAL ATHALA IMC 30
RIESGO DE PREECLAMPSIA INTERMEDIO
RIESGO DE HPP BAJO
PLANIFICACIÓN FAMILIAR POST PARTO: IMPLANTE SUBDÉRMICO

PLAN
SE INICIÓ MANEJO CON ASA
SE ENVIÓ ESPIROMETRÍA- ECOTT Y HOLTER
SE SOLICITO VAL POR PERINATOLOGIA

VAL POR
pacient
tos a pe
hace ur
refiere

EXAMEN
REDUCI

cterizado por
or que desde
ón del sueño

) VESICULAR

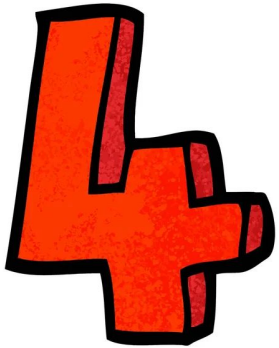
	JESSIKA LISETH TORRES CUBIDES				FECHA	02/08/2025	HORA	5:00:00 PM		
DOCUMENTO	1007307547				EDAD GESTACIONAL	26,2 SEMANAS				
PACIENTE POST PARTO	SI		NO	X	DIAS DE PUERPERIO					
MOTIVO DE CONSULTA	POR QUIE TENGO DIFICULTAD PARA RESPIRAR ME DUELE MUCHO EL PECHO, MAS DE UNA SEMANA									
TENSION ARTERIAL	PAS	PAD	Talla	157		TRIAGE 2 Atención aproximada 30 min	Tipo MEOWS	SIN CLASIFICAR		
	128	71	PESO:	73,3						
SpO2	92		FR:	20						
FRECUENCIA CARDIACA FETAL			FC:	106				PUNTAJE:		
ESTADO DE CONCIENCIA	ALERTA	X	FIO2	Aire ambiente						
	NO ALERTA		TEMP:	35,5						
NIVEL DOLOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DIAGNÓSTICOS
- G2P1V1
- EMBARAZO DE 26.2 SEMANAS
- **ASMA MODERADO SIN MANEJO**

RIESGO OBSTÉTRICO ALTO MADRE CON DIAGNÓSTICO DE THAE
RIESGO ISOINMUNIZACIÓN RH NEGATIVO.
RIESGO TROMBOEMBÓLICO BAJO
RIESGO PSICOSOCIAL: BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: SOBREPESO PARA EDAD GESTACIONAL ATHALA IMC 30
RIESGO DE PREECLAMPSIA INTERMEDIO
RIESGO DE HPP BAJO
PLANIFICACIÓN FAMILIAR POST PARTO: IMPLANTE SUBDÉRMICO

PLAN
* HIDRATAN + CORTICOIDE + MNB

PAciente con posterior mejoria, exámenes hemograma y pcr normales , **dan egreso con bromuro + beclometasona,se insiste en toma de estudio**



19/8/2025

EMBARAZO DE 28.5 SEMANAS POR ECOGRAFÍA DE TAMIZAJE, REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE MOVIMIENTOS FETALES, BUENA ADHERENCIA A MICRONUTRIENTES. NIEGA EPISODIOS DE SANGRADO, ASINTOMÁTICA, NIEGA SÍNTOMAS URINARIOS. NIEGA AMENORREA, NIEGA SÍNTOMAS DE VASOESPASMO- , SIN EMBARGO CON DISNEA NYHA III/ IV, SIN SÍNTOMAS CONGESTIVOS O DE HIPOPERFUSIÓN.

TAS: 124 TAD: 76 TAM: 9.200 F.C.: 101 F.R.: 19 T°: 36 SO2: 95 PERFUSION: <2

31/06/2025 HOLTER RITMO SINUSAL VARIABILIDAD FC CONSERVADA,
8/08/2025 ESPIROMETRÍA PROBABLE RESTRICCIÓN PRE Y POS

IDX
G2P1V1
EMBARAZO DE 28.5 SEMANAS POR ECOGRAFÍA DE TAMIZAJE
ASMA E
TAQUICARDIA SINUSAL PREGESTACIONAL ***
RIESGO OBSTÉTRICO ALTO
RIESGO DE SEROCONVERSIÓN PARA TOXOPLASMA *** IG M NEGATIVO MES DE JUNIO
RIESGO ISOINMUNIZACIÓN RH NEGATIVO O-
ANTE DE MADRE CON THAE
RIESGO TROMBOEMBÓLICO BAJO
RIESGO PSICOSOCIAL: BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: SOBREPESO PARA EDAD GESTACIONAL ATHALA IMC 30
RIESGO DE PREECLAMPSIA INTERMEDIO
RIESGO DE HPP BAJO

PLAN

SIGNOS DE ALARMA Y RECOMENDACIONES

DATOS DEL INGRESO **FOLIO Nº 71** **(Fecha: 19/08/2025 10:12 a. m.)** **Folio Asociado: 64**

Responsable: **Teléfono Resp:**

CURSANDO

- SE EXPLICA LA IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA AL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD: - LA INSTITUCIÓN BRINDA UN CURSO DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD EL ÚLTIMO MIÉRCOLES DE TODOS LOS MESES DE 9 AM A 11 AM EN EL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, DONDE SE INFORMAN LOS CUIDADOS, SIGNOS DE ALARMA DE LA GESTACIÓN, SE MUESTRAN Y SE ENTRENAN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DURANTE LA ATENCIÓN DEL PARTO Y SE BRINDA INFORMACIÓN OPORTUNA A LA PACIENTE Y A SU ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL PROCESO DE LA GESTACIÓN, LACTANCIA MATERNA Y CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO. SE INVITA A LA ASISTENCIA AL MISMO***.
- ACUDIR DE FORMA PERMANENTE A SUS CONTROLES CON LA FRECUENCIA INDICADA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ACUDA A OTROS CONTROLES DE FORMA PARTICULAR- SE RECOMIENDA TRAER REPORTES IMPRESOS DE TODOS LOS EXÁMENES A TODOS LOS CONTROLES ASÍ SEAN TOMADOS DE FORMA PARTICULAR.
- REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA LEVE NO EXTENUANTE PREFERIBLEMENTE ACOMPAÑADA.
- SE EXPLICA SENTENCIA C-055 Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS ASÍ COMO DERECHOS Y DEBERES DE LAS GESTANTES.
- SE EXPLICA QUE LA INSTITUCIÓN CUENTA CON CANALES DE INFORMACIÓN (PAGINA WEB, WHATSAPP, CÓDIGO QR., OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO, ENTRE OTROS) DONDE PODRÁ ACLARAR DUDAS RESPECTO A LA SOLICITUD DE CITAS MÉDICAS, AGENDAMIENTO PARA TOMA DE ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS.

*** SE INDICA BUSQUEDA ACTIVA DE PREECLAMPSIA CON TOMA DE TA DIARIA Y PESO SEMANAL SI TA > 140 / 90 ASISTIR POR URGENCIAS , SE RECOMIENDA TRAER REPORTE AL PRÓXIMO CONTROL ** SE EXPLICA NO CONSUMIR AGUAS NATURALES COMO DE BREVO O DERIVADOS **

- SE EXPLICA IMPORTANCIA LAVADO DE MANOS, CUIDADOS GENERALES EN SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA Y SIGNOS DE ALARMA DEL COVID 19 Y SE EXPLICAN DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES Y LAS GESTANTES, REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.

NO DEBE TOMAR DESPUÉS DE LAS 37 SEMANAS AGUAS AROMÁTICAS O DE HIERBAS, ESPECIALMENTE AGUA DE BREVO, MANZANILLAS O RAMO,UVAS PASAS TAMPOCO DEBE REALIZAR BAÑOS CON NINGÚN TIPO DE HIERBA PARA ADELANTAR SU TRABAJO DE PARTO DADO ALTO RIESGO DE HEMORRAGIAS POSPARTO Y

Procedimiento 881202 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO

Dolor durante el procedimiento

Descripción

NOMBRE:JESSIKA LISETH TORRES CUBIDES
CC:1007307547
EDAD : 27 AÑOS
PESO : 57 Kg
TALLA 173 cm
SC 1.74

FECHA: 19 DE AGOSTO DEL 2025

ESTUDIO REALIZADO CON EQUIPO: PHILIPS CX 50, SONDA S51, DOPPLER COLOR, CONT ENCONTRANDOSE:

CALIDAD DE LA VENTANA: ADECUADA

MEDIDAS
Raíz aórtica : 22mm
Apertura aórtica: 16mm
Aurícula izquierda: 25mm
Ventrículo derecho diástole: 27mm
Pared septal: 8 mm
Diámetro fin de diástole: 31 mm
Pared posterior: 7 mm
Diámetro de fin de sístole: 20 mm
IMVI: 53 g/m²
GRP: 0.42

DESCRIPCION:
VENTRÍCULO IZQUIERDO: forma y tamaño normal, VFD: 40ml/m² | VFS: 15ml/m² , fracción de e

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.] NIT [891800395-1]

(SIMPSON). no se observan trombos intracavitarios
CONTRACTILIDAD SEGMENTARIA:
Septal inferior: normal
Anterolateral: normal
Inferior: normal
Anterior: normal
Inferolateral: normal
Septal anterior: normal

FUNCION DIASTOLICA DEL VI no valorable por flujo monofasico

VENTRÍCULO DERECHO TAPSE 20 mm, onda S: 16cm/seg,

AURÍCULA IZQUIERDA volumen 19 ml/m2sc. (VN < 34 ml/m²)

AURÍCULA DERECHA Area: 12.2 cm² / volumen 15 ml/m2sc. (VN : H < 30. M < 28 ml/m²)

TABIQUE INTERAURICULAR: Íntegro.

TABIQUE INTERVENTRICULAR: Íntegro.

VÁLVULA MITRAL Morfología y estructura normal, Sin gradientes estenóticos.

VÁLVULA AÓRTICA Es trivalva, V.max: 1.39 m/seg gradiente pico de 7.7 mmHg.

VÁLVULA PULMONAR Morfología y estructura normal, arterias pulmonares de diámetros normales, TAP 90 mseg

VÁLVULA TRICÚSPIDE: Morfológicamente normal, no se evidencia jet de insuficienciasin |cálculo de PSAP
VENA CAVA INFERIOR Normal

AORTA De diámetros normales, velocidades normales.

PERICARDIO De aspecto normal.

CONCLUSIONES:

VENTRÍCULO IZQUIERDO DE FORMA Y TAMAÑO NORMAL CON FUNCION SISTOLICA CONSERVADA FEVI 63%
PLANOS VALVULARES MITRAL Y AORTICO NORMALES
VENTRÍCULO DERECHO DE TAMAÑO Y FUNCIÓN NORMAL
SIGNOS INDIRECTOS PARA HIPERTENSION PULMONAR

NOTA: ESTUDIO REALIZADO EN RITMO DE TAQUICARDIA SINUSAL

(Fecha: 19/08/2025 09:08 a. m.)
REPORTE DE ECOCARDIOGRAMA TT

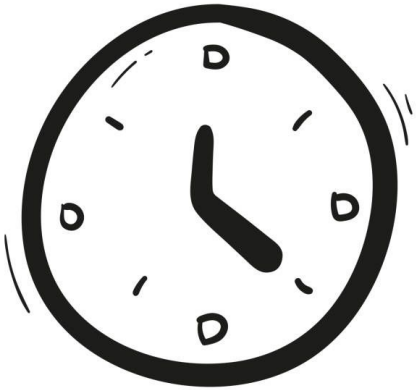
***No cuenta con reporte en hc de holter y espirometría**

INGRESO A URGENCIAS DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA

7/9/2025



| | | |



INGRESA A TRIAJE 6+22

MOTIVO DE CONSULTA: ME SIENTO AHOGADA

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente de 27 años de edad **G2 con embarazo de eg 31.3 semana**s con cuadro clínico **1 día de evolución consistente en disnea de pequeños esfuerzo asociado a disfagia tos ciano zante emetizante sin movilización de secreciones con antecedente de asma, en manejo con bromuro de ipratropio y betametasona sin mejoría de su cuadro**

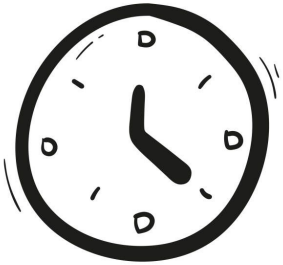
SIGNOS VITALES SV: TA: 130/80 SPO2: 86% FC: 107 LPM FR: 18 T:37°

Q SOFA 0 -PUNTOS MEOWS 2 PUNTO (RIESGO BAJO)

EF : RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS NO MASAS NO MEGALIAS, **RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS NO MASAS NO MEGALIAS, RUIDOS RESPIRATORIOS CON SIBILANCIAS BILATERALES , NO PRESENTA SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA**

IDX
- CRISIS ASMATICA
-RIESGO TROMBOEMBOLICO BAJO

PLAN
L RINGER BOLO DE 500 CC
PARACETAMOL 1 GR IV
MNB CON SALBUTAMOL 20 GOTAS EN 3 CC DE SSN 0.9 % UN CICLO N 3 UNO CADA 20 MINUTOS
HIDROCORTISONA 100 MG IV
S/S CUADRO HEMÁTICO Y PCR



TERAPIA RESPIRATORIA “ Esquema de crisis **
***** PRIMERA SESION 19 +30**
… Requerimiento de **oxígeno suplementario dado por cánula nasal a 3 litros / m con saturación de 92%, sin aumento de la carga de la musculatura respiratoria, con signos de dificultad respiratoria** al momento leves a la auscultación sibilancias espiratorias en ambos campos pulmonares
***** SEGUNDA SESIÓN 19+50**
**** TERCERA SESION 20 +10**
cánula nasal a 3 litros por minuto, con saturación de **91%, sin aumento de la carga de la musculatura respiratoria, sin signos de dificultad respiratoria** al momento , **patron respiratorio superficial,** a la auscultación murmullo vesicular en ambos campos pulmonares . se **finaliza esquema de crisis, con requerimiento de oxígeno suplementario al momento de retirar el oxígeno presenta desaturaciones hasta 85%**

SEGUN LO REGISTRADO * FIO2 33 % MEOWS 1 PUNTO**

REVALORACION

EXÁMENES DE INGRESO

PRC 0.8
SARAS COV2 NEGATIVO
HEMOGRAMA LEU 9.8700 NEU 75.1 HB 15.6 HTO 46.9 PLAQ 257.000
MONITORIA FETAL , ACOG I , NTS REACTIVA, LÍNEA DE BASE 145 LPM,ACELERACIONES PRESENTES DESACELERACIONES AUSENTES, SIN DINAMICA UTERINA

Paciente de 27 años G2 con embarazo de 31+2 sem con ant de asma, sin diagnósticos espirométrico con cuadro clínico descrito, **en el momento con SIGNOS VITALES : FR 23 RPM SAT 95 CON CNS A 2L/ MINUTO, FC 100 LPM, TA 100/75 ,** sin sirs, normotenso, no taquicardia, afebril **CON POLIPNEA SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA , A LA AUSCULTACIÓN PULMONAR, CON SIBILANCIA BILATERALES DE PREDOMINIO BASAL, SIN OTROS AGREGADOS,** bienestar fetal por clínica y monitoria fetal sin cambios cervicales se revalora con exámenes de ingreso. dentro de limites normales antigeno covid 19 negativo considero **paciente con exacerbación asmática moderada con parcial control de síntomas, dado a requerimiento de oxígeno suplementario, se indica continuar con inhaloterapia dual, junto corticoide sistémico,** segun evolución clínica se definirá conductas adicionales, se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

8/9/2025 00+00

MEOWS : 2 PUNTOS
QSOFA : 1 PUNTO

PLAN
HOSPITALIZACION GINECOLOGIA
CABECERA 45 °
DIETA NORMAL
OXÍGENO POR CNS PARA SAT >95%
MNB CON AEROVIAL CADA HORA POR 4 HORAS LUEGO CADA 6 HRS
HIDROCORTISONA 100 MG IV CADA 8 HRS
TERAPIA RESPIRATORIA CADA 8 HRS
MONITORIA FETAL POR TURNO
FETOCARDIA INTERMITENTE
CURVA TERMICA CADA 4 HRS
VIGILAR PATRON RESPIRATORIO
CSV-AC

8/9/2025 4+30

Paciente con persistencia de requerimiento de oxígeno a bajo flujo,s e indica toma de rx de tórax con protección abdominal , gases arteriales , dado a respuesta pobre a corticoide, se escalona el mismo (Dosis de 250 mg iv metilprednisolona)

8/9/2025 5+01

Toma de gases arteriales
FIO2 DEL 36%

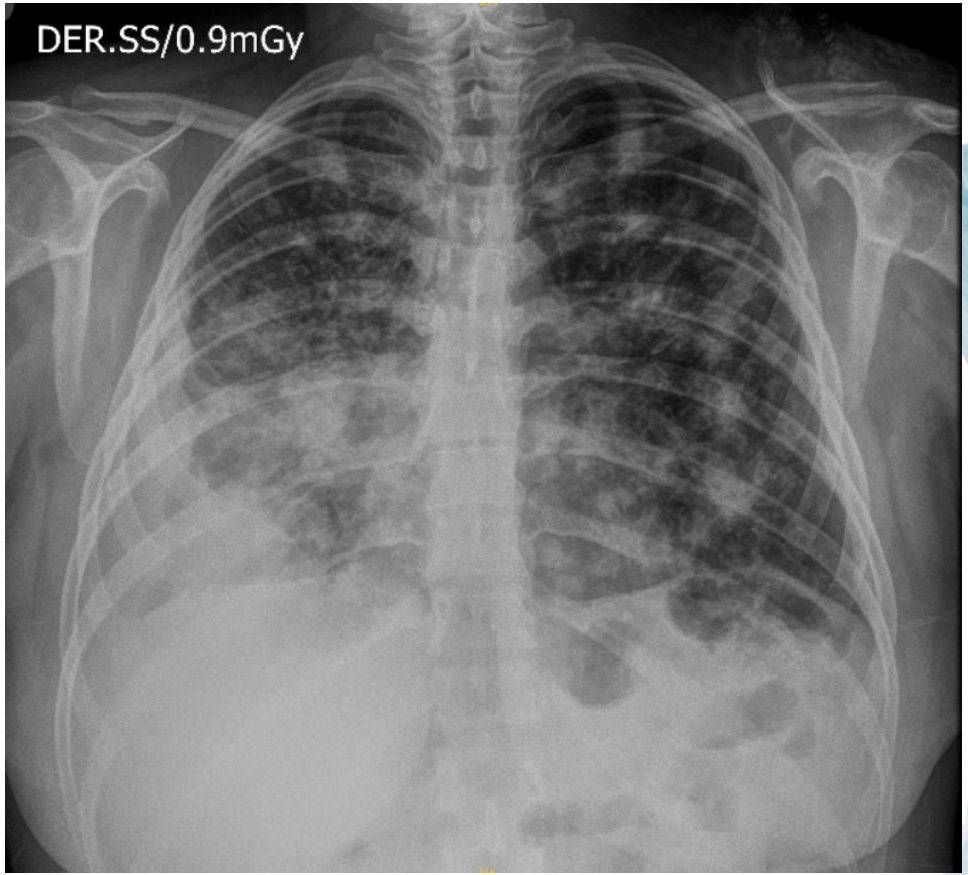
MEWS : 1 Punto
QSOFA : 1 PUTNO (FR)

Hora	Signo Vital	Valor
05:00 a. m.	FRECUENCIA CARDIACA	109
05:00 a. m.	FRECUENCIA RESPIRATORIA	18
05:00 a. m.	TEMPERATURA	35.3
05:00 a. m.	TENSION ARTERIAL	110/122
05:00 a. m.	SATURACION DE OXIGENO	91

REPORTE DE LABORATORIOS

PH 7.46 PCO2 26.2 PO2 75.0
HCO3 19.1 BE -4.8 PO2/FIO 208.2
LAT 1.8

RX DE TORAX AP Y LATERAL :
ÁNGULOS COSTOFRÉNICOS CONSERVADOS,CON INFILTRADOS DIFUSOS
IMPRESIÓN CONSOLIDACIÓN EN LÓBULO MEDIO



Paciente con gestación con ant de asma, en contexto de aumento de sintomatología respiratoria accesos de tos, polipnea y disnea, sin expectoración, sin pico febril en manejo sintomático con esquema con corte inhalado + LABA + corticoide sistémico, labs de de ingreso con pcr negativo hemogram sin leucocitosis con leve neutrofilia sars cov 19 negativo, dado a persistencia de requerimiento de oxígeno para mantener sat >95 % polipnea,disnea en reposo se decide escalonar corticoide sistémico y **se solicita gases arteriales con evidencia de alcalosis respiratoria con trastorno moderado de la oxigenación , rx de tórax con evidencia infiltrados alveolares impresiona consolidación de lóbulo medio derecho, dado a mala evolución clínica de paciente, persistencia de polipnea,disnea y saturaciones limítrofes se indica ajustar tratamiento y escalona oxígeno suplementario, p**aciente con factores de riesgo **sospecho ciris asmática severa sobreinfectada posible neumonía por gérmenes atípico q sofa de 1 punto,** se indica perfil de severidad, se solicita valoración por medicina interna y ginecología para definir incio de manejo antibiótico según evolución se definirá conducta a seguir

IDX
- G2P1V1
- EMBARAZO DE 31.2 SEMANAS POR ECO
- **CRISIS ASMATICA SEVERA ? SOBREINFECTADA**
- **NEUMONIA DQUIRUDA EN LA COMUNIDAD Q OSFA 1 PUNO**
- RIESGO OBSTÉTRICO ALTO MADRE CON DIAGNOSTICO DE THAE

RIESGO ISOINMUNIZACIÓN RH NEGATIVO.
RIESGO TROMBOEMBÓLICO BAJO



8/9/2025 6+22

PLAN

MONITORIZACION CONTINUA
CABECERA 45 °
MASCARA DE NOREINHLACION >95%
LR 100 CC/ H
MNB CON AEROVIAL CADA 4 HRS
METILPREDNISOLONA 250 MG IV CADA 12 HR
TERAPIA RESPIRATORIA CADA 8 HR
MONITORIA FETAL POR TURNO
FETOCARDIA INTERMITENTE
CURVA TERMICA CADA 4 HRS
VIGILAR PATRON RESPIRATORIO
SS// PERFIL DE SEVERIDAD
SS// VAL POR GINECOLOGIA Y MEDICINA INTERNA
CSV-AC

SOLICITUD DE VALORACIONES INTERDISCIPLINARIAS

MEDICINA INTERNA 6+22
GINECOLOGIA 6+22

VALORACIÓN POR GINECOLOGÍA : 8/9/2025 7+00

SIGNOS VITALES
TA: 123/76 FR 18 SPO2:98% FC 88
LPM CON RESERVORIO
RESPIRATORIO A 4 L/ M
QSOFA 0 PUNTOS MEOWS 1 PUNTO

.. Se considera por parte de ginecología inicio de manejo antibiótico, manejo con omeprazol y tromboprofilaxis, se explica conducta quien relata entender y aceptar..

PLAN

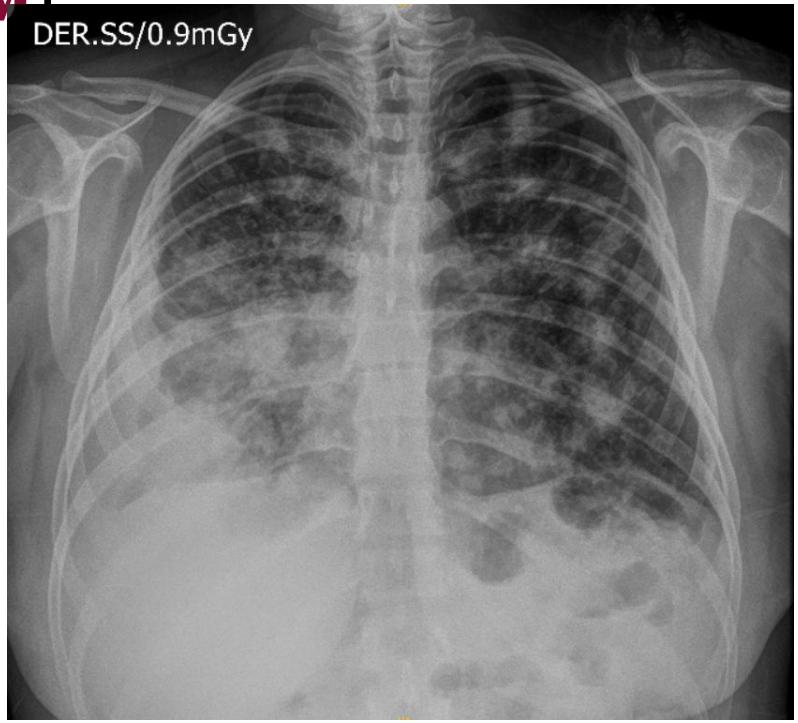
HOSPITALIZAR EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.
MONITORIZACION CONTINUA
CABECERA 45 °
MASCARA DE NOREINHLACION >95%
LR 100 CC/ H
OMEPRAZOL 40 MG IV CADA DIA
AMPICILINA SULBACTAM 3 GR IV CADA 6 HORAS
CLARITROMICINA 500MG ORAL CADA 12 HORAS
MNB CON AEROVIAL CADA 4 HRS
METILPREDNISOLONA 250 MG IV CADA 12 HR
ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA
TERAPIA RESPIRATORIA CADA 8 HR
MONITORIA FETAL POR TURNO
FETOCARDIA INTERMITENTE
CURVA TERMICA CADA 4 HRS
VIGILAR PATRON RESPIRATORIO
PENDIENTE PERFIL DE SEVERIDAD
PENDIENTE VALORACIÓN POR MEDICINA INTERNA
CSV AC

INTERCONSULTA MEDICINA INTERNA 08/09/2025 (9+30 AM)

MC: DISNEA

RESPUESTA

SE TRATA DE PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS DE EDAD G2P1V1 CON EMBARAZO DE 31.2 SEMANAS POR ECOGRAFÍA ANTECEDENTE DE ASMA BRONQUIAL CON CUADRO CLÍNICO DE 1 DIA DE EVOLUCION DE MÚLTIPLES ACCESOS DE TOS NO PRODUCTIVA NO FIEBRE SI REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO SUPLEMENTARIO EN MANEJO POR SERVICIO DE GINECOLOGÍA CON INICIO DE LABA Y ESTEROIDE ENDOVENOSO EN EL MOMENTO DE LA VALORACIÓN EN REGULARES CONDICIONES GENERALES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO SUPLEMENTARIO POR MÁSCARA DE NO REINHALACIÓN. MANTIENE MECÁNICA PULMONAR CON RONCUS Y SIBILANCIAS DE PREDOMINIO EN BASE PULMONAR DERECHA SE REVISAN PARACLÍNICOS HEMOGRAMA SIN LEUCOCITOSIS NI NEUTROFILIA, GASES ARTERIALES CON ALCALOSIS RESPIRATORIA Y DISFUNCIÓN PULMONAR LEVE SIN HIPERLACTATEMIA. RADIOGRAFÍA DE TÓRAX CON INFILTRADOS DE PREDOMINIO EN BASE DERECHA CON FOCO DE CONSOLIDACIÓN SE CONSIDERA CURSA CON CRISIS ASMÁTICA SEVERA SOBREINFECTADA QUIEN REQUIERE MANEJO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS .



OPACIDAD DE OCUPACIÓN ALVEOLAR DIFUSAS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES.OBLITERACIÓN DEL SENO COSTOFRÉNICO DERECHO, HALLAZGO COMPATIBLE CON DERRAME PLEURAL.

INTERCONSULTA MEDICINA INTERNA 08/09/2025 (9+30 AM)

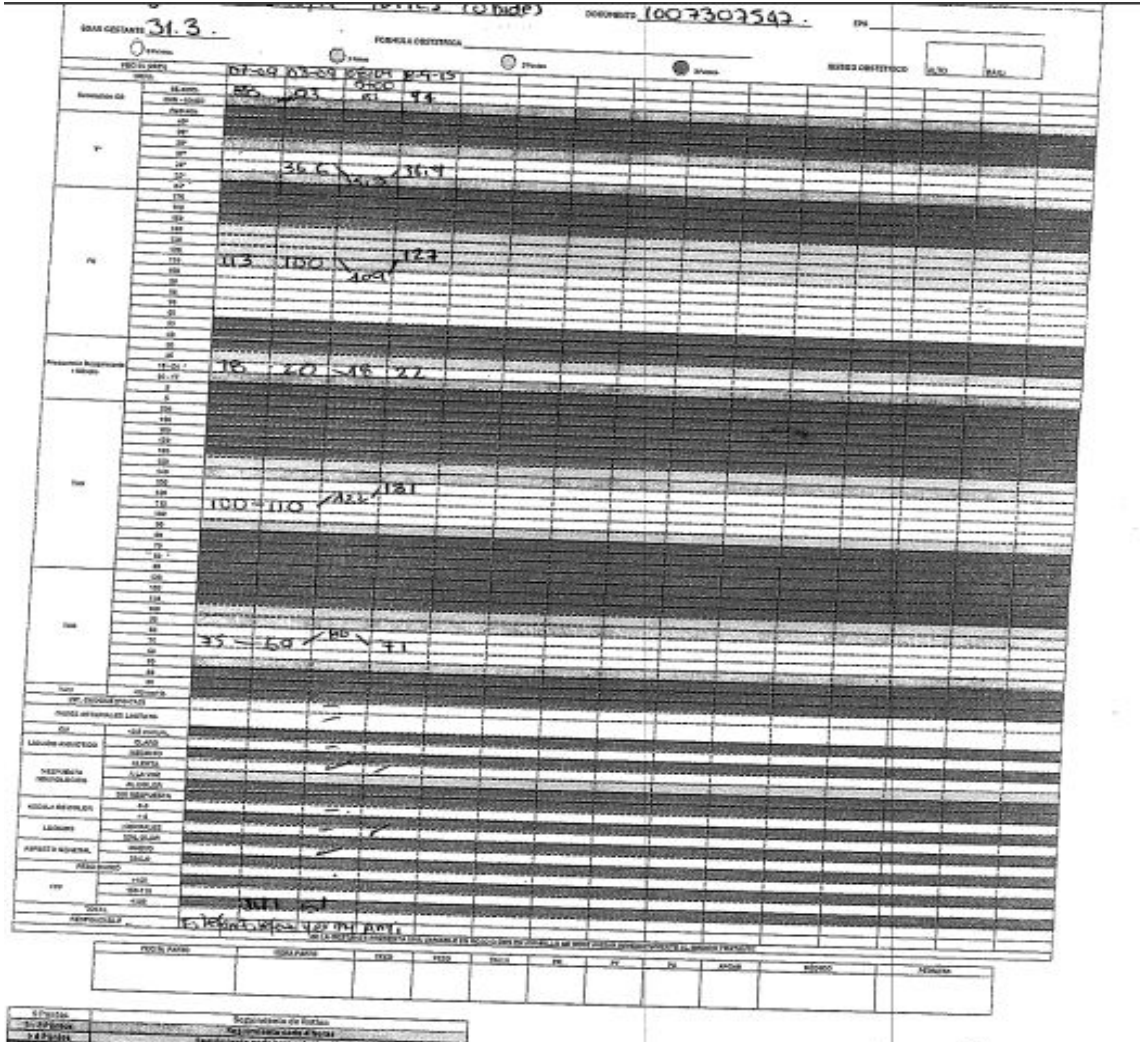
IMPRESION DIAGNOSTICA
- CRISIS ASMÁTICA SEVERA PERSISTENTE
- NEUMONÍA MULTILOBAR ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB65 0 PTOS ATS/IDSA 3 CRITERIOS MENORES
- G2P1V1
- EMBARAZO DE 31.2 SEMANAS POR ECO
- DESCARTAR INFECCIÓN ACTIVA POR SARS COV 2

TRASLADO A UCI INTERMEDIO
HOSPITALIZAR EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.
MONITORIZACIÓN CONTINUA CABECERA 45 °
MÁSCARA DE NOREINHALACIÓN >95%
LR 100 CC/ H
OMEPRAZOL 40 MG IV CADA DIA
AMPICILINA SULBACTAM 3 GR IV CADA 6 HORAS
CLARITROMICINA 500MG ORAL CADA 12 HORAS MNB

12:00 p. m.	FRECUENCIA CARDIACA	113
12:00 p. m.	FRECUENCIA RESPIRATORIA	19
12:00 p. m.	TEMPERATURA	35.9
12:00 p. m.	TENSION ARTERIAL	136/83
12:00 p. m.	SATURACION DE OXIGENO	94

07/09/2025 - 19+42
HEMOGRAMA
Recuento de Leucocitos 9.87 x10e3/uL
Neutrofilos 75.1 %
Linfocitos 20.0 %
Monocitos 4.6 %
Eosinofilos 0.3 %
Basofilos 0.0 %
Recuento de Eritrocitos 5.31 x10e6/uL
Hemoglobina 15.6 g/dL
Hematocrito 46.9 %
Volumen Corpuscular Medio 88.3
HB Corpuscular Media 29.5 pg
Concentración HB Corpuscular Media 33.4 g/dL
Ancho Distribución Eritrocitaria (IDE-CV) 12.9 %
Recuento de Plaquetas 257 x10e3/uL
Volumen Plaquetario Medio 9.6 fL
Indice de Distribución Plaquetario (IDP) 15.9 um3 -
Plaquetocrito (PCT) 0.245 % 0.15 - 0.50

GASES ARTERIALES: PH 7.46 PCO2 26.2 PO2 75.0 HCO3 19.1 BE -4.8 PO2/FIO 208.2 LAT 1.8



INTERCONSULTA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 08/09/2025 (10+00 AM)

MC: PACIENTE 27 AÑOS G2P1V1 CON NEUMONÍA CON UN GRAVE TRASTORNO DE LA FUNCIÓN PULMONAR

RESPUESTA

ACEPTADA: REQUIERE VIGILANCIA EN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO POR ALTO RIESGO DE FRACASO RESPIRATORIO Y REQUERIMIENTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA



INGRESO A UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 08/09/2025 (11+00 AM)

MC: INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

EA: PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS DE EDAD CON EMBARAZO DE 31.2 SEMANAS Y ANTECEDENTE DE ASMA CON MÚLTIPLES EXACERBACIONES A LA SEMANA Y GRAVE LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA QUIEN REFIERE CUADRO DE APROXIMADAMENTE 15 DÍAS DE EVOLUCIÓN CONSISTENTE EN EMPEORAMIENTO DE LA CLASE FUNCIONAL, DIAFORESIS, MAYOR DIFICULTAD RESPIRATORIA Y DOLOR A NIVEL DE BASE DE HEMITÓRAX DERECHO EN CARA ANTERIOR Y POSTERIOR DEL TÓRAX , REFIERE QUE LOS MISMOS HAN PROGRESADO EN EL TIEMPO LLEGANDO A IMPOSIBILITAR LA EMISIÓN DE FRASES COMPLETAS POR DIFICULTAD RESPIRATORIA Y LA MOVILIDAD POR LO CUAL CONSULTA, ES VALORADA POR LOS SERVICIOS DE GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA QUIENES REALIZAN RADIOGRAFÍA DE TÓRAX EN LA CUAL SE EVIDENCIAN MÚLTIPLES INFILTRADOS INTERSTICIALES Y ALGODONOSOS EN LOS CUATRO CUADRANTES CON FRANCA CONSOLIDACIÓN EN LA BASE PULMONAR DERECHA, POR ESTO SOLICITAN TRASLADO A CUIDADO INTENSIVO PARA EVALUACIÓN Y MANEJO.

JUSTIFICACIÓN ESTANCIA:
- REQUERIMIENTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA
-REQUERIMIENTO DE MONITORIA DEL BIENESTAR BINOMIO MATERNO FETAL CONTINUO
- RIESGO OBSTETRICO ALTO
- ALTO RIESGO DE DETERIORO CARDIOVASCULAR
- SOPORTE DEL MEDIO INTERNO
- ALTO REQUERIMIENTO DE ENFERMERÍA
- MONITORIZACIÓN CARDIOVASCULAR CONTINUA
- VIGILANCIA NEUROLÓGICA ESTRICTA

EXAMEN FISICO:
PACIENTE EN MAL ESTADO GENERAL CON MARCADA DIFICULTAD RESPIRATORIA, TAQUIPNEIA, AGITADA.

- DISCURSO ENTRECORTADO SOLO LOGRANDO EMITIR UNA O DOS PALABRAS.
- GRAVES SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, ESFUERZO MUSCULAR Y TIRAJES SUBCOSTALES
- MURMULLO VESICULAR BIBASAL DISMINUIDO CON ESTERTORES GENERALIZADOS
- ABDOMEN GLOBOSO POR UTERO GRAVIDO, FCF: 121 X MINUTO
- SONDA VESICAL CON DRENAJE A CISTOFLO

08/09/2025 RADIOGRAFÍA DE TÓRAX OPACIDAD DE OCUPACIÓN ALVEOLAR DIFUSAS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. OBLITERACIÓN DEL SENO COSTOFRÉNICO DERECHO, HALLAZGO COMPATIBLE CON DERRAME PLEURAL.
EKG: RITMO SINUSAL FC: 111 X MIN, EJE 30°, ESCASA PROGRESIÓN DE ONDA R EN PRECORDIALES SIN SIGNOS COMPATIBLES CON ISQUEMIA AGUDA
GLUCOMETRÍA: 126 MG/DL DE INGRESO A UCI
GASES ARTERIALES: 08/09/2025 05:00 AM PH 7.46 PCO2 26.2 PO2 75.0 HCO3 19.1 BE -4.8 PO2/FIO 208.2, LACT 1.8 ALCALOSIS RESPIRATORIA COMPENSADA CON TRASTORNO LEVE DE LA OXIGENACIÓN SIN HIPERLACTATEMIA
08/09/2025 12:00 AM (7 HORAS DESPUÉS) : PH 7.43 PCO2 27 PO2 73 HCO3 18 BE -5.6 PO2/FIO 132, LACT 2.7 EQUILIBRIO ACIDO BASE CON TRASTORNO MODERADO DE LA OXIGENACIÓN CON HIPERLACTATEMIA

ANALISIS:
PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS DE EDAD CON GESTACIÓN DE 31 SEMANAS QUIEN INGRESA POR CUADRO DE DIFICULTAD RESPIRATORIA Y RADIOGRAFÍA DE TÓRAX CON INFILTRADOS EN LOS CUATRO CUADRANTES, SE REVISAN IMAGENES CON UN GRAVE COMPROMISO DEL PARÉNQUIMA PULMONAR GENERALIZADO, LA GASOMETRÍA ARTERIAL MUESTRA UN RAPIDO Y PROGRESIVO DETERIORO DE LA FUNCIÓN PULMONAR EN POCAS HORAS , AL EXAMEN FÍSICO ENCUENTRO UNA PACIENTE CON SIGNOS DE INMINENCIA DE FRACASO RESPIRATORIO POR LO CUAL BAJO SECUENCIA DE INDUCCION RAPIDA SE REALIZA INTUBACION OROTRAQUEAL, SE REALIZA LARINGOSCOPIA (CORMACK III), SE INTRODUCE TUBO OROTRAQUEAL NUMERO 7.5 Y SE FIJA A LA COMISURA LABIAL A 23 CM, SE COMPRUEBA ADECUADO POSICIONAMIENTO CON AUSCULTACIÓN Y CURVAS DE VENTILACIÓN MECANICA, SE REALIZA MEDICION DE MECANICA VENTILATORIA ENCONTRANDO UNA GRAVE DISMINUCION DE LAS COMPLACENCIAS PULMONARES, CON ELASTANCIA ELEVADA, SIN EMBARGO CON ADECUADA RESPUESTA A UNA MANIOBRA DE RECLUTAMIENTO ALVEOLAR, SE REALIZA TITULACION DE PEEP BASADO EN LA MEJOR COMPLACENCIA ENCONTRANDO EN 10 EL MEJOR VALOR, POR EL MOMENTO DEBIDO A UN ACOPLE VENTILATORIO DIFICULTOSO SE DECIDE INICIO DE INFUSION DE RELAJANTE MUSCULAR Y POSTERIOR A UN ADECVUADO ACOPLE SE REALIZARA CONTROL GASOMETRICO EN DOS HORAS PARA DETERMINAR SI REQUIERE VENTILACION EN DECUBITO PRONO.

EN EL ASPECTO CARDIOVASCULAR LA PACIENTE MUESTRA TENSIONES ARTERIALES CON TENDENCIA AL ALZA, EL LACTATO ARTERIAL TOMADO EN GASES PREVIOS MUESTRA UN AUMENTO EN PROBABLE RELACION CON FATIGA MUSCULAR, POR EL MOMENTO NO HAY REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOPRESOR, SE INDICA CAMBIO PERIODICO DE POSICION PRIORIZANDO DECUBITO LATERAL IZQUIERDO. A LA VALORACION DEL BINOMIO MATERNO FETAL SE REALIZARA MANEJO CONJUNTO CON EL SERVICIO DE GINECOLOGIA, SE PLANTEA LA REALIZACION DE MONITORIAS FETALES CADA 12 HORAS Y EL DIA DE HOY UNA ECO OBSTÉTRICA PARA EVALUACION DE BIENESTAR FETAL, EN EL MOMENTO NO HAY INDICACIÓN PARA INTERRUPCIÓN DE LA GESTACIÓN YA QUE ESTA NO GENERA EN EL MOMENTO EMPEORAMIENTO DE LA FUNCIÓN CARDIOVASCULA, NI RESPIRATORIA POR LO CUAL HASTA EL MOMENTO CONTINUAREMOS CON TODOS LOS ESFUERZOS QUE ORIENTEN AL MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR MATERNO FETAL, DEBIDO A QUE LA PACIENTE RECIBE DOSIS ALTAS DE ESTEROIDES ENDOVENOSOS NO REQUIERE DOSIS ADICIONALES PARA MADURACIÓN PULMONAR. SE SOLICITA REALIZACION DE JUNTA MEDICA ENTRE LOS SERVICIOS DE GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y CUIDADO INTENSIVO. LA FUNCIÓN RENAL Y EL GASTO URINARIO SON NORMALES, DESDE EL PUNTO DE VISTA INFECTOLOGICO SE TOMAN CULTIVOS DE SANGRE, SECRECIONES RESPIRATORIAS, SE SOLICITA PANEL VIRAL Y PRUEBA DE COVID, ASI COMO PANEL DE DETECCION MOLECULAR DE MULTIPLES PATOGENOS EN SECRECIONES RESPIRATORIAS DADA LA PRESENTACION PROLONGADA EN EL TIEMPO, AUSENCIA DE RESPUESTA INFLAMATORIA GRAVE EN ESTA PACIENTE Y EL USO PROLONGADO DE ESTEROIDES DE FORMA DIARIA POR SU ANTECEDENTE DE ASMA. , SE SOLICITA CONCEPTO POR INFECTOLOGÍA CON QUIENES SE DECIDE AMPLIAR COBERTURA PARA PSEUDOMONA CON CEFEPIME.

IDX

- SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO SEVERO DEL ADULTO EN PACIENTE GESTANTE
- NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA
- ASMA PERSISTENTE MODERADA/GRAVE
- G2P1V1
- EMBARAZO DE 31.2 SEMANAS POR ECO
- CRISIS ASMATICA SEVERA SOBREINFECTADA ?
- RIESGO OBSTÉTRICO ALTO MADRE CON DIAGNOSTICO DE THAE RIESGO ISOINMUNIZACION RH NEGATIVO. RIESGO TROMBOEMBÓLICO

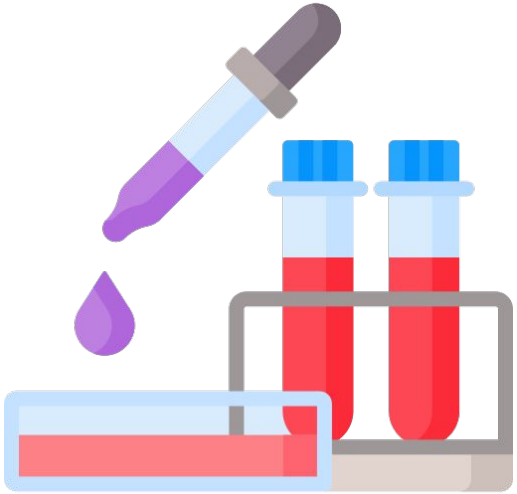
BAJO RIESGO PSICOSOCIAL:
BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: SOBRESPESO PARA EDAD GESTACIONAL ATHALA IMC 30 RIESGO DE PREECLAMSIA INTERMEDIO EN MANEJO CON ASA

PLAN:

VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA
- NUTRICION ENTERAL CON ENSURE, META A DEFINIR
- PROPOFOL INFUSION CONTINUA TITULABLE DE 1 - 4 MG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- FENTANILO INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 1-3 MCG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
-- CISATRACURIO INFUSIÓN CONTINUA A 1 A 2 MCG/KG/MIN - HIDROCORTISONA INFUSION CONTINUA DE 200 MG IV PARA 24 HORAS
- CEFEPIME 2 GR IV CADA 8 HORAS FI: 08/09/2025 - CLARITROMICINA 500MG ORAL CADA 12 HORAS
- OMEPRAZOL 40MG IV CADA DIA
- ENOXAPARINA 40MG SC CADA DIA
- ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG VIA ENTERAL CADA DIA
- CARBONATO DE CALCIO 600 MG VIA ENTERAL CADA 12 HORAS
- BISACODILO 5 MG VIA ENTERAL CADA 12 HORAS - SALBUTAMOL 15 PUFF CADA 6 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO 15 PUFF CADA 8 HORAS

PARACLINICOS INGRESO

Tiempo de Protrombina - PT 8.7 Seg 8.9- 11.9
INR 0.792
Tiempo Parcial de Tromboplastina 25.5 Seg 24.5- 33.8
Nitrogeno Ureico - BUN 12.0 mg/dl 7.5- 22.5
CREATININA 0.72 mg/dl 0.6 1.1
SODIO SÉRICO 142.8 mmol/l 135 148
POTASIO SÉRICO 5.46 mmol/l 3.5- 5.1
CLORO EN SANGRE 104.1 mmol/l 98 110
MAGNESIO 2.2 mg/dl 1.6- 2.5
BILIRRUBINAS
Bilirrubina Total 0.7 mg/dl 0.2 1.2
Bilirrubina Directa 0.4 mg/dl 0.0 0.2 Bilirrubina Indirecta 0.30 mg/d 1 0.2 1.0
Amilasa 53.7 U/L Hasta 90
Troponina I de Alta Sensibilidad: 0,03 ng/ml
TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA-ALT 19.2 U/L 5.0 32.0
TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA(AST) 31.6 U/L 5.0 31.0
DESHIDROGENASA LÁCTICA [LDH] 598.0 U/L 230.0- 460.0
ÁCIDO ÚRICO 5.15 mg/dl 2.5 6.8
PROTEÍNA C REACTIVA. CUANTITATIVO 1.8 mg/L 0.5 6.0
HEMOGRAMA LEU 20.21 x10e3/uL NEU 88.2 %LINF 11.3 % HB 17.7 g/dL HTO Hematocrito 55.4 % PLT 330 x10e3/uL 1



NOTA RETROSPECTIVA 08/09/2025 (17+30)

DESDE EL PUNTO DE VISTA VENTILATORIO LA PACIENTE MUESTRA UN CONTROL DE GASOMETRÍA ARTERIAL QUE EVIDENCIA UNA MEJORÍA LEVE N LA FUNCIÓN PULMONAR SIN EMBARGO CON UNA GRAVE ACIDOSIS RESPIRATORIA POR LO CUAL SE REALIZA PASO A MODO APRV COMO RESCATE
EN EL ASPECTO CARDIOVASCULAR LA PACIENTE MUESTRA TENSIONES ARTERIALES NORMALES A LA VALORACIÓN DEL BINOMIO MATERNO FETAL EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA, REALIZA EVALUACIÓN ECOGRÁFICA DE BIENESTAR FETAL EL CUAL ES DESFAVORABLE POR LO CUAL SE DECIDE PASAR A SALAS DE CIRUGÍA PARA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO DE FORMA URGENTE POR LO CUAL SE ACTIVA CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA. LA FUNCIÓN RENAL Y EL GASTO URINARIO SON NORMALES. DESDE EL PUNTO DE VISTA INFECTOLÓGICO SE RECIBE REPORTE DE LAS PRUEBAS MOLECULARES LAS CUALES REPORTAN POSITIVIDAD PARA RINOVIRUS, POR EL MOMENTO NO SE REALIZAN CAMBIOS DEBIDO A QUE NO EXISTE MANEJO ESPECÍFICO PARA ESTO, CONTINUAREMOS CON LAS MEDIDAS DE SOPORTE INSTAURADAS. SE TRASLADA PACIENTE A SALAS DE CIRUGÍA EN LAS CONDICIONES DESCRITAS, CONTINUARA EN UCI PARA CONTROL POSTOPERATORIO.

INFLUENZA A Antígeno NEGATIVO
. INFLUENZA B Antígeno NEGATIVO
ADENOVIRUS: NEGATIVO
MICROSCOPIA GRAM Cocos Gram Positivos +
CULTIVO DE GÉRMENES COMUNES
CRECIMIENTO DE MICROBIOTA HABITUAL

08/09/2025 17+30

Listado de estudios:

- ECOGRAFÍA

Descripcion del procedimiento

*** ECOGRAFIA OBSTETRICA TRANSABDOMINAL
BIOMETRIA:
Ver Anexo.
DBP:78.6 mm para 32 semanas0 días
CC: 277 mm para 30 semanas 2 días
CA: 260 mm para 30 semanas 1 días
LF: 57 mm para 30 semanas0 días
PEF 1546 gr
P: 12
HALLAZGOS
Feto único vivo, en situación longitudinal, presentación cefálico dorso izquierdo.
Placenta corporal anterior G II/III, de 31 mm de espesor. Cordón umbilical de tres vasos.
Líquido amniótico normal 11.1cm.
Cráneo: Estructuras intracraneanas normales. Cara: labio superior íntegro.
Cuello: normal. Columna vertebral: íntegra Tórax: normal.
Corazón: Situs solitus, corte de cuatro cámaras normal. FCF 140 lpm.
Abdomen: Pared anterior y diafragma íntegros. Hígado normal. Cámara gástrica, riñones y presentes normales. No se observa patología intestinal. Ecogenicidad abdominal normal.
Extremidades: morfología y movilidad normales.

OPINIÓN:
EMBARAZO DE 30 SEMANAS 0 DIAS POR BIOMETRIA FETAL.
DESACELERACION EN CURVA DE CRECIMIENTO FETAL

ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA CON PERFIL BIOFÍSICO

Feto único vivo en situación longitudinal cefálico dorso izquierdo FCF: 140 lat/min.
Placenta corporal posterior grado III/III de maduración de 31 mm de espesor.

Movimientos Fetales	0	
Movimientos Respiratorios	0	
Tono Fetal	0	
Líquido amniótico	2	
Perfil biofísico		2/8

ILA: 11 cm

PERFIL BIOFÍSICO: 2/8

**NOTA GINECOLOGIA
PACIENTE DE 27 AÑOS G2P1V1 CON EMBARAZO DE 31.2 SEMANAS HOSPITALIZADA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS POR SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO SEVERO DEL ADULTO Y NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD -CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA Y ASMA PERSISTENTE MODERADA/GRAVE A **QUIEN SE LE REALIZA PERFIL BIOFÍSICO** CON 8/8 POR ILA NO SE EVIDENCIAN MOVIMIENTOS FETALES NI RESPIRATORIOS NI TONO FETAL , FETOCARDIA EN 140 ,SE CONSIDERA DADO EL RÁPIDO DETERIORO DE LA PACIENTE CON LOS ALTOS REQUERIMIENTOS VENTILATORIOS Y LA PERSISTENCIA DE LA ACIDOSIS ASOCIADO AL PERFIL BIOFÍSICO 2/8 FINALIZACIÓN DE LA GESTACIÓN POR VÍA ALTA **SE ACTIVA EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA OBSTÉTRICA PARA FINALIZACIÓN DE LA GESTACIÓN POR VÍA ALTA** , SE AVISA A SALAS DE CIRUGÍA Y
PEDIATRIA , SE TOMA DECISIÓN EN CONJUNTO CON UCI , EN EL MOMENTO NO HAY FAMILIAR PARA DAR INFORMACIÓN
***

NOTA - ADAPTACIÓN NEONATAL

DATOS IMPORTANTES DEL RECIÉN NACIDO

FC: 145
FR: 60
SAT: 95
PESO (g): 1.810
TALLA (cm): 41
PC: 29

PT: 27
PA: 26

SEXO: MASCULINO
A TERMINO: NO
RESPIRO ESPONTANEAMENTE: NO
MANIOBRAS RC: SI
BALLARD: 31 SEMANAS
SILVERMAN: PTS

APAGAR AL MINUTO: 3 A LOS MINUTOS: 4 A LOS 10 MINUTOS: 8

DIAGNOSTICOS

1. ENFERMEDAD POR DEFICIT DE SURFACTANTE
2. ALTO RIESGO DE SEPSIS NEONATAL
3. RECIEN NACIDO PRETERMINO ADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONAL

PLAM

1. REMISION A III NIVEL PARA VALORACION POR Y MANEJO EN UCI NEONATAL COMO URGENCIA VITAL
2. NADA VIA ORAL
3. MONITORIZACION CONTINUA
4. DAD 10% A 7 CC HORA POR BOMBA DE INFUSION CONTINUA
5. AMPICILINA 180 MGIV CADA 12 HORAS
6. GENTAMICINA 10 MG IV AHORA
7. OXIGENO POR TUBO ENDOTRAQUEAL A 6 LT MIN
8. SS GASES ARTERIALES
9. CSV-AC

EL DIA 08-09-2025 A LAS
17+50 SIN FRECUENCIA RESPIRATORIA, SE OBTIENE RN SIN LLANTO, SIN FRECUENCIA CARDIACA, POR LO CUAL SE PROCEDE A DAR ESTÍMULO TÁCTIL, POSTERIOR COMPRESIONES TORÁCICA Y VENTILACION CON PRESION POSITIVA CON NEOPUFF RELACION 3-1, CON POSTERIOR FRECUENCIA CARDIACA MAYORA100XMIN Y RESPIRACIÓN TIPO GASPING POR LO CUAL SE PROCEDE A REALIZACIÓN INTUBACION OROTRAQUEAL CON TUBO
2.5 FIJADO A 8 CC DE COMISURA LABIAL CON ADECUADA EXPANSIÓN TORÁCICA, SE AUSCULTA MURMULLO VESICULAR BILATERAL, ADECUADA COLUMNA DE AIRE Y MEJORIA EN SATURACION DE OXIGENO PROGRESIVA DESDE 84% HASTA CONSEGUIR CIFRAS DE 92-94% CON FIO2 A 6 LTMIN, SE CONECTA OXIGENO A NEOPUFF CON PEE 5 PRESION MAXIMA 15 MMGHG, SE PROCEDE A SUMINISTRAR DOSIS DE SUFACTANTE PULMONAR SURVANTA) 3 CC EN CADA CAMPO PULMONAR CON MEJORIA DE SATURACION PULMONAR EN EL MOMENTO 94%, SE PROCEDE A COLOCAR CATETER UMBILICAR 3.5 FRENCH SE FIJA EN 8 CM SE SUCCIONA OBTENIENDO
ADECUADO RETORNO, SE PSAN 3 CC DE DEXTROSA AL 105%, SE FIJA CATETER CON PROLENE 3.0 SIN

EVOLUCIÓN NOCHE 08/09/2025 (24+00)

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS CON DIAGNÓSTICOS DE:
-POP INMEDIATO CESÁREA 08/09/2025 G2P2V2 APGAR 3-8-8
-SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO SEVERO DEL ADULTO EN PACIENTE GESTANTE
- NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD -INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA
- ASMA PERSISTENTE MODERADA/GRAVE -EMBARAZO DE 31.2 SEMANAS POR ECO
- CRISIS ASMÁTICA SEVERA SOBREINFECTADA ? -RIESGO OBSTÉTRICO ALTO MADRE CON DIAGNÓSTICO DE TAHE
-RIESGO ISOINMUNIZACIÓN RH NEGATIVO
-RIESGO TROMBOEMBÓLICO
-BAJO RIESGO PSICOSOCIAL
-BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
-SOBREPESO PARA EDAD GESTACIONAL ATHALA IMC 30
-RIESGO DE PREECLAMPSIA INTERMEDIO EN MANEJO CON ASA

08/09/2025 POSTQX CON MODO CONTROLADO POR VOLUMEN EN SALAS: PH 7.214 PCO2 57.1 PO2 85.1 LACTAO 1.4 HCO3 23.2 D(A-a) 317.5 PAFI 106.4

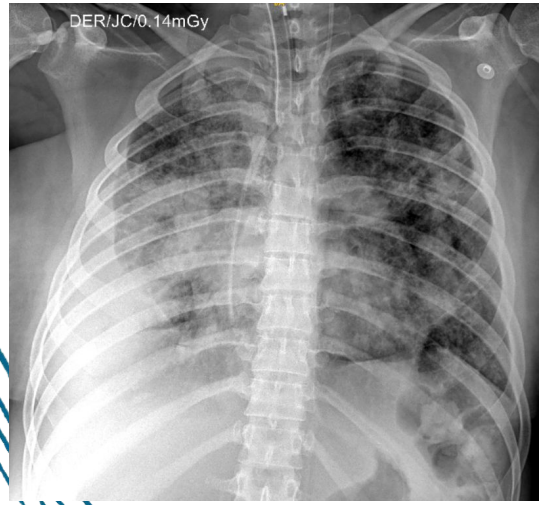
08/09/2025 05:00 AM PH 7.46 PCO2 26.2 PO2 75.0 HCO3 19.1 BE -4.8 PO2/FIO 208.2, LACT 1.8

08/09/2025 12:00 AM (7 HORAS DESPUÉS) : PH 7.43 PCO2 27 PO2 73 HCO3 18 BE -5.6 PO2/FIO 132, LACT 2.7

BALANCE HÍDRICO 6 HORAS
ADMINISTRADOS: 768 CC
ELIMINADOS 1500
GASTO URINARIO 3
BALANCE: -731

- **PROPOFOL** INFUSION CONTINUA TITULABLE DE 1 - 4 MG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- **FENTANILO** INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 1-3 MCG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- **CISATRACURIO** INFUSIÓN CONTINUA A 1 A 2 MCG/KG/MIN
-**VMI P**RONO MODO APRV VT: 6.5 ML/KG, PHIGH 28 PLOW 0 THIGH 4 TLOW 1.2 FIO2 50%
- NO REQUIERE SOPORTE VASOPRESOR
- **ENSURE 10 CC**
- HIDROCORTISONA INFUSION CONTINUA DE 200 MG IV PARA 24 HORAS
- CEFEPIME 2 GR IV CADA 8 HORAS FI: 08/09/2025
- CLARITROMICINA 500MG ORAL CADA 12 HORAS
- OMEPRAZOL 40MG IV CADA DIA
- ENOXAPARINA 40MG SC CADA DIA
- ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG VIA ENTERAL CADA DIA
- CARBONATO DE CALCIO 600 MG VIA ENTERAL CADA 12 HORAS
- BISACODILO 5 MG VIA ENTERAL CADA 12 HORAS
- SALBUTAMOL 15 PUFF CADA 6 HORAS - BROMURO DE IPRATROPIO 15 PUFF CADA 8 HORAS

NOTA RETROSPECTIVA 09/09/2025



OPACIDADES DE OCUPACIÓN ALVEOLAR MULTILOBARES BILATERALES CON TENDENCIA A LA CONSOLIDACIÓN. OBLITERACIÓN DEL RECESO COSTOFRÉNICO DERECHO QUE SUGIERE DERRAME PLEURAL. ELEMENTOS DE MONITORIA EXTERNA.



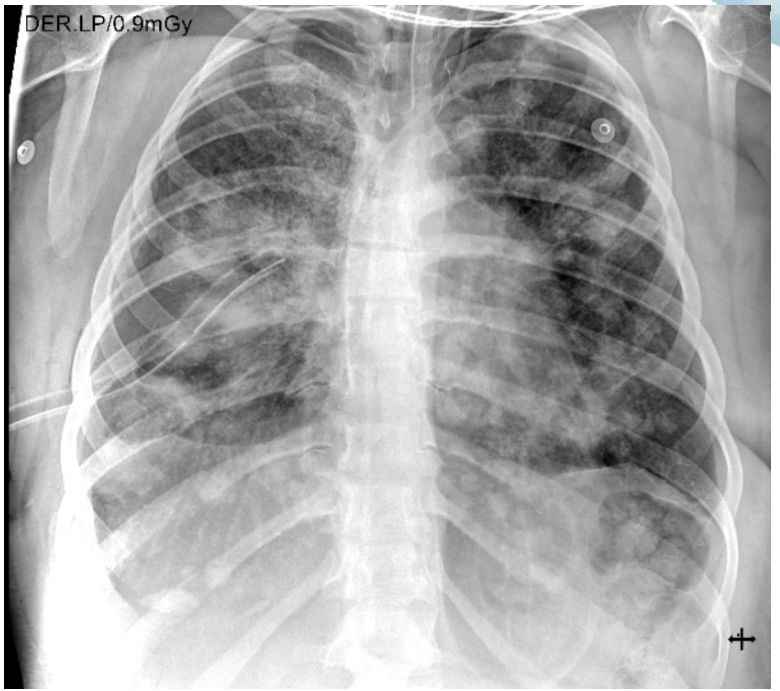
NEUMOTÓRAX DERECHO CON UNA DISTANCIA INTERPLEURAL DE 46 MM A NIVEL DEL HILIO PULMONAR. OPACIDADES MIXTAS DIFUSAS EN AMBOS HEMITÓRAX. SILUETA CARDIACA DE TAMAÑO NORMAL. OBLITERACIÓN DE LOS SENOS COSTOFRÉNICOS DE FORMA BILATERAL, HALLAZGO EN PROBABLE RELACIÓN CON DERRAMES PLEURALES

UN PACIENTE HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO POR UN SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO SEVERO DEL ADULTO CON REQUERIMIENTO DE VENTILACIÓN EN DECÚBITO PRONO POR HIPOXEMIA REFRACTARIA. SE REVISA EL DÍA DE HOY LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX EN LA CUAL SE EVIDENCIA UN IMPORTANTE DERRAME DEL HEMITÓRAX DERECHO CON UN COMPONENTE COMPRESIVO SOBRE EL PARÉNQUIMA PULMONAR. SE EVIDENCIA UNA COLECCIÓN DE ASPECTO HETEROGÉNEO DE DIFÍCIL CARACTERIZACIÓN, MOTIVO POR LA CUAL SE DECIDE BAJO GUÍA ECOGRÁFICA REALIZAR UNA TORASENTESIS DIAGNÓSTICA. EN LA LÍNEA AXILAR POSTERIOR ENTRE EL DÉCIMO Y ONCEAVO ESPACIO INTERCOSTAL Y BAJO GUÍA ECOGRÁFICA SE REALIZA UNA PUNCIÓN CON AGUJA DE 20 CENTÍMETROS, CORRECCIÓN JERINGA DE 20 CENTÍMETROS Y AGUJA DE 3 CENTÍMETROS DE LONGITUD. SE OBTIENE SALIDA DE LÍQUIDO CLARO CON ALGUNOS GRÁNULOS SANGUINOLENTOS, EL CUAL SE ENVÍA PARA ESTUDIO. POSTERIOR A ESTO, LA PACIENTE PRESENTA DESATURACIÓN Y REQUERIMIENTO DE AUMENTO DE LA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO, POR LO CUAL SE SOLICITA UNA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX URGENTE. AL ANÁLISIS DE LA MISMA SE EVIDENCIA UNA CÁMARA DE NEUMOTÓRAX DERECHO CON COMPROMISO DE APROXIMADAMENTE 30 Y 40% DE ESTE MITÓRAX. POR ESTA RAZÓN SE SOLICITA VALORACIÓN URGENTE POR EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL PARA INSERCIÓN DE TÓRACOSTOMÍA DE DRENAJE.

RESPUESTA INTERCONSULTA CIRUGÍA GENERAL 09/09/2025

PACIENTE CON NEUMOTÓRAX DERECHO , CON NECESIDAD DE TORACOTOMÍA URGENTE, SE REALIZA SIN COMPLICACIONES, SE REVISA RX DE TÓRAX POSTERIOR A PASO DE TUBO CON EVIDENCIA DE TUBO NORMOPOSICIONADO , CON BUENA EXPANSION, SE CONSIDERA CONTINUAR CON CUIDADOS DE TORACOSTOMÍA Y RETIRO POSTERIOR A EXTUBACIÓN, DE MOMENTO SIN OTRA INDICACIÓN DE MANEJO POR NUESTRO SERVICIO, FAVOR CONSULTAR POSTERIOR A EXTUBACIÓN PARA DEFINIR RETIRO DE TORACOSTOMÍA

Estudio técnicamente limitado por rotación de la proyección.
Silueta cardiaca magnificada.
Vascularización pulmonar de aspecto usual.
Opacidades de ocupación alveolar multilobares bilaterales, con tendencia al consolidación de predominio derecho.
Catéter de acceso yugular izquierdo con extremo distal proyectado en aurícula derecha.
Tubo orotraqueal con extremo distal proyectado a 40 mm de la carina.
Tubo de tórax derecho con extremo distal proyectado en hilio pulmonar derecho.



EVOLUCIÓN DIA 09/09/2025 (8+00AM)

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS CON DIAGNÓSTICOS DE:
-POP INMEDIATO CESÁREA 08/09/2025 G2P2V2 APGAR 3-8-8
-SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO SEVERO DEL ADULTO EN PACIENTE GESTANTE
- NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD -INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA
- ASMA PERSISTENTE MODERADA/GRAVE -EMBARAZO DE 31.2 SEMANAS POR ECO
- CRISIS ASMÁTICA SEVERA SOBREINFECTADA ? -RIESGO OBSTÉTRICO ALTO MADRE CON DIAGNÓSTICO DE TAHE
-RIESGO ISOINMUNIZACIÓN RH NEGATIVO
-RIESGO TROMBOEMBÓLICO
-BAJO RIESGO PSICOSOCIAL
-BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
-SOBREPESO PARA EDAD GESTACIONAL ATHALA IMC 30
-RIESGO DE PREECLAMPSIA INTERMEDIO EN MANEJO CON ASA

09/09/2025 : GASES ARTERIALES: PH: 7.39 , PCO2_ 33, PO2. 78 , HCO3: 21 PAFI: 262, SATO2: 95%, LAC: 1.4 , BE - 4.0, HB: 14 //
09/09/2025 GASES ARTERIALS: PH: 7.34 , PCO2_ 43 , PO2. 71 , HCO3: 23 PAFI: 205 , SATO2: 95%, LAC: 1.4 , BE - 2.1 , HB: 15 // ACIDOSIS RESPIRATORIA NO COMPENSADA, DISFUNCION PULMONAR MODERADA SIN HIPERLACTATEMIA.

09/09/2025 HEMOGRAMA LEU: 26.1 NEU : 93.2 LINF: 2.9 HG : 15.9 HCTO: 49.3 PLA: 250 CR: 0.79 BUN : 19.2 NA : 140 K: 4.85 CL : 103.4 MG : 1.8 TGO: 24.9 TGP: 17.8 BT: 0.7 BD : 0.3 BI : 0.4

BALANCE HÍDRICO 24 HORAS
ADMINISTRADOS: 2766 CC
ELIMINADOS 1600 CC GASTO URINARIO :1.2 CC KG HORA
BALANCE: -1166 CC
BALANCE ACUMULADO. 1166 CC

-**NOREPINEFRINA** INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 0.05 -2.0 MCG/KG/MIN
- **PROPOFOL** INFUSION CONTINUA TITULABLE DE 1 - 4 MG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- **FENTANILO** INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 1-3 MCG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- **CISATRACURIO** INFUSIÓN CONTINUA A 1 A 2 MCG/KG/MIN
-**VMI P**RONO MODO APRV VT: 6.5 ML/KG, PHIGH 28 PLOW 0 THIGH 4 TLOW 1.2 FIO2 50%
- NO REQUIERE SOPORTE VASOPRESOR
- **ENSURE 10 CC**
- HIDROCORTISONA INFUSION CONTINUA DE 200 MG IV PARA 24 HORAS
- CEFEPIME 2 GR IV CADA 8 HORAS FI: 08/09/2025
- CLARITROMICINA 500MG ORAL CADA 12 HORAS
- OMEPRAZOL 40MG IV CADA DIA
- ENOXAPARINA 40MG SC CADA DIA
- ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG VIA ENTERAL CADA DIA
- CARBONATO DE CALCIO 600 MG VIA ENTERAL CADA 12 HORAS
- BISACODILO 5 MG VIA ENTERAL CADA 12 HORAS
- SALBUTAMOL 15 PUFF CADA 6 HORAS - BROMURO DE IPRATROPIO 15 PUFF CADA 8 HORAS

EVOLUCIÓN TARDE 09/09/2025 (18+00PM)

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS CON DIAGNÓSTICOS DE:
- POP TORACOSTOMIA CERRADA DERECHA 09/09/2025
-SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO SEVERO DEL ADULTO EN PACIENTE GESTANTE
- NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD PSI SCORE Clase V (riesgo alto)
- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA - POSTOPERATORIO CESÁREA 08/09/2025 G2C1P1V2
- RECIEN NACIDO MASCULINO APGAR 3-4-8
- ASMA PERSISTENTE MODERADA/GRAVE
- EMBARAZO DE 31.2 SEMANAS POR ECO
- CRISIS ASMATICA SEVERA
- RIESGO OBSTÉTRICO ALTO MADRE CON DIAGNÓSTICO DE THAE
-RIESGO ISOINMUNIZACIÓN RH NEGATIVO
-RIESGO TROMBOEMBOLICO
-BAJO RIESGO PSICOSOCIAL
-BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL SOBREPESO PARA EDAD GESTACIONAL ATHALA IMC 30

09/09/2025 : GASES ARTERIALES: PH: 7.16 , PCO2: 46 , PO2: 70 , HCO3: 16.8 , PAFI : 233 , SAT: 88%, LAC5.9 , BE : - 12 , HB : 17.4 // T. EXTRACCION DELTA CO2: 23, DELTA 11.4 // ACIDOSIS METABOLICA NO COMPENSADA, DSIFUNCION PULMONAR MODERADA CON HIPERLACTATEMIA
09/09/2025 : GASES ARTERIALES: PH: 7.39 , PCO2_ 33, PO2. 78 , HCO3: 21 PAFI: 262, SATO2: 95%, LAC: 1.4 , BE - 4.0, HB: 14 //

09/09/2025 HEMOGRAMA LEU : 27.9 NEU : 92 LINF : 1.2 HG : 16.2 HCTO: 49.7 PLA: 249 CREATININA : 1.39 BUN . 26 NA . 141 K : 5.21 CL : 103 MG : 2.3 09/09/2025 11:28 AM ALBUMINA 3.4 LDH 578.1 LIQUIDO PLEURAL DENSIDAD 1.010 PH 8.5 PROTEINAS 1.9 GLUCOSA 53.4 DESHIDROGENASA LACTICA 914 LINFOCITOS 3.100 NEUTROFILOS 18 MONO**CITOS 62 HEMATIES 70.000**

BALANCE HÍDRICO 24 HORAS
ADMINISTRADOS: 2766 CC
ELIMINADOS 1600 CC
GASTO URINARIO :1.2 CC KG HORA BALANCE: -1166 CC
BALANCE ACUMULADO. 1166 CC

-**NOREPINEFRINA** INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 0.05 -2.0 MCG/KG/MIN
- **PROPOFOL** INFUSION CONTINUA TITULABLE DE 1 - 4 MG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- **FENTANILO** INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 1-3 MCG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- **CISATRACURIO** INFUSIÓN CONTINUA A 1 A 2 MCG/KG/MIN
-**VMI P**RONO MODO APRV VT: 6.5 ML/KG, PHIGH 28 PLOW 0 THIGH 4 TLOW 1.2 FIO2 50%
- NO REQUIERE SOPORTE VASOPRESOR
- **ENSURE 10 CC**
- HIDROCORTISONA INFUSION CONTINUA DE 200 MG IV PARA 24 HORAS
- CEFEPIME 2 GR IV CADA 8 HORAS FI: 08/09/2025
- CLARITROMICINA 500MG ORAL CADA 12 HORAS
- OMEPRAZOL 40MG IV CADA DIA
- ENOXAPARINA 40MG SC CADA DIA
- ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG VIA ENTERAL CADA DIA
- CARBONATO DE CALCIO 600 MG VIA ENTERAL CADA 12 HORAS
- BISACODILO 5 MG VIA ENTERAL CADA 12 HORAS
- DIPIRONA 2 GR IV SI FIEBRE PERSISTENTE
- FUROSEMIDA 80 MG IV **NUEVO**
- SALBUTAMOL 15 PUFF CADA 6 HORAS - BROMURO DE IPRATROPIO 15 PUFF CADA 8 HORAS

EVOLUCIÓN NOCHE 09/09/2025 (23+00PM)

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS CON DIAGNÓSTICOS DE:
- POP TORACOSTOMIA CERRADA DERECHA 09/09/2025
-SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO SEVERO DEL ADULTO EN PACIENTE GESTANTE
- NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD PSI SCORE Clase V (riesgo alto)
- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA - POSTOPERATORIO CESÁREA 08/09/2025 G2C1P1V2
- RECIEN NACIDO MASCULINO APGAR 3-4-8
- ASMA PERSISTENTE MODERADA/GRAVE
- EMBARAZO DE 31.2 SEMANAS POR ECO
- CRISIS ASMATICA SEVERA
- RIESGO OBSTÉTRICO ALTO MADRE CON DIAGNÓSTICO DE THAE
-RIESGO ISOINMUNIZACIÓN RH NEGATIVO
-RIESGO TROMBOEMBOLICO
-BAJO RIESGO PSICOSOCIAL
-BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL SOBREPESO PARA EDAD GESTACIONAL ATHALA IMC 30

09/09/2025 : GASES ARTERIALES: PH: 7.16 , PCO2: 46 , PO2: 70 , HCO3: 16.8 , PAFI : 233 , SAT: 88%, LAC5.9 , BE : - 12 , HB : 17.4 // T. EXTRACCION DELTA CO2: 23, DELTA 11.4 // ACIDOSIS METABOLICA NO COMPENSADA, DSIFUNCION PULMONAR MODERADA CON HIPERLACTATEMIA
09/09/2025 : GASES ARTERIALES: PH: 7.39 , PCO2_ 33, PO2. 78 , HCO3: 21 PAFI: 262, SATO2: 95%, LAC: 1.4 , BE - 4.0, HB: 14 //

09/09/2025 HEMOGRAMA LEU : 27.9 NEU : 92 LINF : 1.2 HG : 16.2 HCTO: 49.7 PLA: 249 CREATININA : 1.39 BUN . 26 NA . 141 K : 5.21 CL : 103 MG : 2.3 09/09/2025 11:28 AM ALBUMINA 3.4 LDH 578.1 LIQUIDO PLEURAL DENSIDAD 1.010 PH 8.5 PROTEINAS 1.9 GLUCOSA 53.4 DESHIDROGENASA LACTICA 914 LINFOCITOS 3.100 NEUTROFILOS 18 MONO**CITOS 62 HEMATIES 70.000**

HIPERTERMIAS

-**NOREPINEFRINA** INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 0.05 -2.0 MCG/KG/MIN
- **PROPOFOL** INFUSION CONTINUA TITULABLE DE 1 - 4 MG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- **FENTANILO** INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 1-3 MCG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- **CISATRACURIO** INFUSIÓN CONTINUA A 1 A 2 MCG/KG/MIN
-**VMI P**RONO MODO APRV VT: 6.5 ML/KG, PHIGH 28 PLOW 0 THIGH 4 TLOW 1.2 FIO2 50%
- NO REQUIERE SOPORTE VASOPRESOR
- **ENSURE 10 CC**
- HIDROCORTISONA INFUSION CONTINUA DE 200 MG IV PARA 24 HORAS
- CEFEPIME 2 GR IV CADA 8 HORAS FI: 08/09/2025
- CLARITROMICINA 500MG ORAL CADA 12 HORAS
- OMEPRAZOL 40MG IV CADA DIA
- ENOXAPARINA 40MG SC CADA DIA
- ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG VIA ENTERAL CADA DIA
- CARBONATO DE CALCIO 600 MG VIA ENTERAL CADA 12 HORAS
- BISACODILO 5 MG VIA ENTERAL CADA 12 HORAS
- DIPIRONA 2 GR IV SI FIEBRE PERSISTENTE
- FUROSEMIDA 80 MG IV **NUEVO**
- SALBUTAMOL 15 PUFF CADA 6 HORAS - BROMURO DE IPRATROPIO 15 PUFF CADA 8 HORAS

EVOLUCIÓN DIA 10/09/2025 (8+00AM)

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS CON DIAGNÓSTICOS DE:
- POP TORACOSTOMIA CERRADA DERECHA 09/09/2025
-SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO SEVERO DEL ADULTO EN PACIENTE GESTANTE
- NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD PSI SCORE Clase V (riesgo alto)
- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA - POSTOPERATORIO CESÁREA 08/09/2025 G2C1P1V2
- RECIEN NACIDO MASCULINO APGAR 3-4-8
- ASMA PERSISTENTE MODERADA/GRAVE
- EMBARAZO DE 31.2 SEMANAS POR ECO
- CRISIS ASMATICA SEVERA
- RIESGO OBSTÉTRICO ALTO MADRE CON DIAGNÓSTICO DE THAE
-RIESGO ISOINMUNIZACIÓN RH NEGATIVO
-RIESGO TROMBOEMBOLICO
-BAJO RIESGO PSICOSOCIAL
-BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL SOBREPESO PARA EDAD GESTACIONAL ATHALA IMC 30

10/09/2025: GASES ARTERIALES: PH: 7.38 , PCO2: 33 , PO2: 58 , HCO3: 20 , PAFI : 223 , SAT: 89%, LAC ,2.5 , BE : - 5 , HB : 15 // EQUILIBRIO ACIDO BASE, DSIFUNCION PULMONAR MODERADA CON HIPERLACTATEMIA EN MEJORIA A PUNTO E LA NORMALIZACION
09/09/2025 : GASES ARTERIALES: PH: 7.16 , PCO2: 46 , PO2: 70 , HCO3: 16.8 , PAFI : 233 , SAT: 88%, LAC5.9 , BE : - 12 , HB : 17.4 // T. EXTRACCION DELTA CO2: 23, DELTA 11.4 // ACIDOSIS METABOLICA NO COMPENSADA,

BALANCE HÍDRICO 24 HORAS
ADMINISTRADOS: 6765 CC ELIMINADOS 4130 CC
GASTO URINARIO :1.9 CC KG HORA
BALANCE: +2635 CC
BALANCE ACUMULADO. +3802 CC

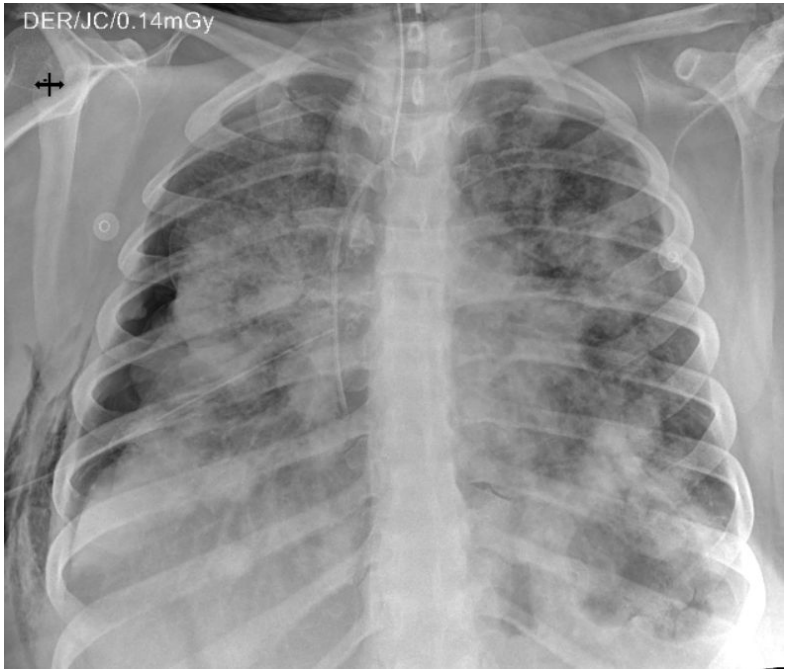
HIPERTERMIAS
10/09/2025 HEMOGRAMA LEU : 21.4 NEU : 90, LINF : 4.3 HG : 15.7 HCTO: 48, PLA: 166000 CREATININA : 1.3 BUN :31 NA: 142 K : 4.08 CL : 107 MG : 2.4, CA:8, P: 4, TGO: 20. TGP: 30, TROPONINA: 0.9, PCR: 41, PT: 12, INR 1.15, PTT: 37, FIBRINOGENO: 147, TGC: 346, FERRITINA: MAYOR A 1500

-**NOREPINEFRINA** INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 0.05 -2.0 MCG/KG/MIN
- **PROPOFOL** INFUSION CONTINUA TITULABLE DE 1 - 4 MG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- **FENTANILO** INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 1-3 MCG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- **CISATRACURIO** INFUSIÓN CONTINUA A 1 A 2 MCG/KG/MIN
-**VMI P**RONO MODO APRV VT: 6.5 ML/KG, PHIGH 28 PLOW 0 THIGH 4 TLOW 1.2 FIO2 50%
- NO REQUIERE SOPORTE VASOPRESOR
- **ENSURE 50 CC**
- HIDROCORTISONA INFUSION CONTINUA DE 200 MG IV PARA 24 HORAS
- CEFEPIME 2 GR IV CADA 8 HORAS FI: 08/09/2025
- CLARITROMICINA 500MG ORAL CADA 12 HORAS
- OMEPRAZOL 40MG IV CADA DIA
- ENOXAPARINA 40MG SC CADA DIA
- ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG VIA ENTERAL CADA DIA
- CARBONATO DE CALCIO 600 MG VIA ENTERAL CADA 12 HORAS
- BISACODILO 5 MG VIA ENTERAL CADA 12 HORAS
- DIPIRONA 2 GR IV SI FIEBRE PERSISTENTE
-BOLO DE 500 CC DE LACTATO DE RINGER A 4 GRADOS POR SONDA OROGASTRICA PARA MANEJO DE TEMPERATURA
- SALBUTAMOL 15 PUFF CADA 6 HORAS - BROMURO DE IPRATROPIO 15 PUFF CADA 8 HORAS

PARACLINICOS RUTINA 10/09/2025

Tiempo de Protrombina - PT 12.3 Seg 8.9- 11.9
INR 1.151
Tiempo Parcial de Tromboplastina 37.2 Seg 24.5- 33.8
Nitrogeno Ureico - BUN 31.9 mg/dl 7.5- 22.5
CREATININA 1.30 mg/dl 0.6 1.1
SODIO SERICO 142.3 mmol/l 135 148
POTASIO SERICO 4.08 mmol/l 3.5- 5.1
CLORO EN SANGRE 107.8 mmol/l 98 110
MAGNESIO 2.4 mg/dl 1.6- 2.5
BILIRRUBINAS
Bilirrubina Total 0.4 mg/dl 0.2 1.2
Bilirrubina Directa 0.2 mg/dl 0.0 0.2 Bilirrubina Indirecta 0.20 mg/dl 0.2 1.0
Amilasa 218.9 U/L Hasta 90
T**roponina I de Alta Sensibilidad**: 0,99 ng/ml
TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA-ALT 30.9 U/L 5.0 32.0
TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA(AST) 20.3 U/L 5.0 31.0

HEMOGRAMA LEU 21.4 NEU 90 LINF 4.3 HB 15.7 HCTO 48.1 PLQ 166



Focos de consolidación difuso en ambos campos pulmonares. Neumotórax derecho con una distancia interpleural a nivel del hilio pulmonar de 23 mm. Silueta cardiaca no valorable por interposición de densidades. Obliteración de los senos costofrénicos de forma bilateral. Catéter venoso central de acceso yugular izquierdo con extremo distal en topografía de la aurícula derecha. Tubo orotraqueal localizado a 35 mm de la carina. Tubo de toracostomía con extremo distal proyectado en zona basal del hemitórax derecho. Enfisema subcutáneo paracostal derecho.

NOTA RETROSPECTIVA 10/09/2025

PACIENTE QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA POR UN SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO SEVERO CON HIPOXEMIA REFRACTARIA ACTUALMENTE EN VENTILACIONES DE CÚBITO PRONO COMO ACOPLE DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA HA REQUERIDO LA UTILIZACIÓN DE PROPOFOL Y FENTANILO PARA SEDACIÓN PROFUNDA E INFUSIÓN DE CISATRACURIO COMO RELAJANTE MUSCULAR, LA FUNCIÓN PULMONAR NO MUESTRA CAMBIOS A UN REQUIRIENTE DE VENTILACIÓN EN PRONO A NIVEL CARDIOVASCULAR HAY UN DISCRETO AUMENTO EN EL REQUERIMIENTO DEL SOPORTE VASOPRESOR DURANTE LA TARDE DE HOY, LOS PARÁMETROS DE PERFUSIÓN TISULAR SE MANTIENEN NORMALES, EL GASTO URINARIO ES ADECUADO, SIN EMBARGO LA PACIENTE VENÍA PRESENTANDO UN DETERIORO LEVE PERO PROGRESIVO DE LA FUNCIÓN RENAL SE SOLICITÓ UN CONTROL PARA LA TARDE DE HOY EL CUAL MUESTRA UNA MEJORÍA RESPECTO AL ANTERIOR LA PACIENTE SE ENCUENTRA EL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO CON CEFEPIME, CLARITROMICINA LLAMA FUERTEMENTE LA ATENCIÓN QUE DURANTE LAS 11 HORAS DEL DÍA DE HOY LA PACIENTE HA PRESENTADO CIFRAS DE FIEBRE ENTRE 38 Y 38.8 PESE A LA ADMINISTRACIÓN DE PARACETAMOL ENDOVENOSO, DIPIRONA Y MEDIOS FÍSICOS DE FORMA EXHAUSTIVA ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS FRÍOS POR SONDA NASOGÁSTRICA Y SONDA VESICAL NO SE HA LOGRADO EL CONTROL DE LA MISMA TENIENDO EN CUENTA ESTO SE DECIDE SUSPENDER LA INFUSIÓN DE CISATRACURIO Y SOLICITAR DE FORMA URGENTE LA REALIZACIÓN DE UNA CREATINA FOSFOQUINASA ANTE LA SOSPECHA DE UNA HIPERTERMIA MALIGNA SE SOLICITA EL PROCESAMIENTO URGENTE DE LA MUESTRA PARA EN CASO TAL DE SER REQUERIDO ACTIVAR EL PROTOCOLO HIPERTERMIA MALIGNA

Hallazgo clínico	Manifestación
Acidosis respiratoria	ET CO_2 > 55 mmHg; $PaCO_2$ > 60 mmHg
Cardíaco	Taquicardia sinusal inexplicable, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular
Acidosis metabólica	Déficit de base > 8 m/EqL o pH < 7.25
Rigidez muscular	Rigidez generalizada; rigidez severa del músculo masetero
Degradación muscular	Creatincinasa sérica concentración > 20.000 unidades/L Orina color obscuro Mioglobina urinaria o sérica K+ > 6 mEq/L
Temperatura	Incremento rápido de la temperatura > 38.8 °C
Otros	Reversión rápida de los signos de HM con la administración de dantroleno Elevación de la concentración de creatincinasa en reposo
Historia familiar	Antecedentes por herencia autosómica dominante

CPK TOTAL (CREATIN KINASA TOTAL) 645.8 U/L 5.0 170.0

NO CUMPLE CRITERIOS DE HIPERTERMIA MALIGNA

EVOLUCIÓN NOCHE 10/09/2025 (23+00 PM)

10/09/2025 GASES ARTERIALES PH: 7.28 , PCO2: 44, PO2: 72 , HCO3: 21 , PAFI : 208, SAT: 92%, LAC ,2.5 , BE : -5.6, HB : 14.2 // VENOSO: T.EXTRACCION: 33.1 ,DELTA CO2: 13.8 // ACIDOSIS METABOLICA CONDSIFUNCION PULMONAR SEVERA E HIPERLACTATEMIA.
10/09/2025: GASES ARTERIALES: PH: 7.38 , PCO2: 33 , PO2: 58 , HCO3: 20 , PAFI : 223 , SAT: 89%, LAC ,2.5 , BE : - 5 , HB : 15 // EQUILIBRIO ACIDO BASE, DSIFUNCION PULMONAR MODERADA CON HIPERLACTATEMIA EN MEJORIA A PUNTO E LA NORMALIZACION

BALANCE HÍDRICO 12 HORAS
ADMINISTRADOS: 3616 CC
ELIMINADOS 1200 CC
GASTO URINARIO :1.2 CC KG HORA
BALANCE: +2416 CC

- EVOLUCIÓN ES TÓRPIDO. SU PARTE HEMODINÁMICA CON REQUERIMIENTO DE SOPORTE, VASOPRESOR CON NOREPINEFRINA
- REPORTE DE TROPONINA POSITIVO QUE EN EL CONTEXTO ACTUAL PUEDE ASOCIARSE A MIOCARDIOPATÍA SÉPTICA;
- PENDIENTE, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO
- RESPIRATORIO BAJO VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA CON SEDACIÓN Y ANALGESIA PROFUNDA
- RADIOLÓGICAMENTE APARENTE DETERIORO CON INCREMENTO DEL PATRÓN DE INFILTRADOS MIXTOS DE PREDOMINIO ALVEOLAR. PRESENCIA DE NEUMOTÓRAX RESIDUAL DERECHO.
- REPORTE DE FILMARRAY RESPIRATORIO POSITIVO PARA RINOVIRUS.
- FIEBRE PERSISTENTE,
- DESCARTA PRESENCIA DE POTASIO, SEVERAMENTE ELEVADO Y RABDOMIÓLISIS
- FIEBRE INICIÓ SU ASCENSO SOSTENIDO POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN DE LA GESTACIÓN
- DETERMINAR PACIENTE CANDIDATA PARA TERAPIA DE SOPORTE EXTRA CORPÓREO ECMO

HIPERTERMIAS

-**NOREPINEFRINA** INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 0.05 -2.0 MCG/KG/MIN
- **PROPOFOL** INFUSION CONTINUA TITULABLE DE 1 - 4 MG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- **FENTANILO** INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 1-3 MCG/KG/HORA **PARA RASS -4** BIS 30-40
- **CISATRACURIO** INFUSIÓN CONTINUA A 1 A 2 MCG/KG/MIN
-**VMI P**RONO MODO APRV VT: 6.5 ML/KG, PHIGH 28 PLOW 0 THIGH 4 TLOW 1.2 FIO2 50%
- NO REQUIERE SOPORTE VASOPRESOR
- **ENSURE 50 CC**
- HIDROCORTISONA INFUSION CONTINUA DE 200 MG IV PARA 24 HORAS
- CEFEPIME 2 GR IV CADA 8 HORAS FI: 08/09/2025
- CLARITROMICINA 500MG ORAL CADA 12 HORAS
- OMEPRAZOL 40MG IV CADA DIA
- ENOXAPARINA 40MG SC CADA DIA
- ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG VIA ENTERAL CADA DIA
- CARBONATO DE CALCIO 600 MG VIA ENTERAL CADA 12 HORAS
- BISACODILO 5 MG VIA ENTERAL CADA 12 HORAS
- DIPIRONA 2 GR IV SI FIEBRE PERSISTENTE
- NAPROXENO 250 MG VO CADA 8 HORAS
-BOLO DE 500 CC DE LACTATO DE RINGER A 4 GRADOS POR SONDA OROGASTRICA PARA MANEJO DE TEMPERATURA
- SALBUTAMOL 15 PUFF CADA 6 HORAS - BROMURO DE IPRATROPIO 15 PUFF CADA 8 HORAS

EVOLUCIÓN DIA 11/09/2025 (8+00 AM)

- PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS CON DIAGNÓSTICOS DE:
  -SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO SEVERO DEL ADULTO
- NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD PSI SCORE Clase V (riesgo alto) -
- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA - POP
- TORACOSTOMÍA CERRADA DERECHA 09/09/2025
- NEUMOTÓRAX DERECHO
- POSTOPERATORIO CESÁREA 08/09/2025 G2C1P1V2
- RECIÉN NACIDO MASCULINO APGAR 3-4-8
- PUERPERIO MEDIATO
- INJURIA RENAL AGUDA AKIN I
- INJURIA MIOCARDICA ASOCIADA A LA SEPSIS
- ASMA PERSISTENTE MODERADA/GRAVE
- CRISIS ASMATICA SEVERA
- RIESGO OBSTÉTRICO ALTO MADRE CON DIAGNÓSTICO DE THAE

11/09/2025 GASES ARTERIALES PH: 7.32 , PCO2: 41, PO2: 70 , HCO3: 21 , PAFI : 200, SAT: 92%, LAC 1.6 , BE : -4.5, HB : 15 // ACIDOSIS METABOLICA CON DSIFUNCION PULMONAR SEVERA SIN HIPERLACTATEMIA. 11/09/2025 GASES ARTERIALES PH: 7.29 , PCO2: 43, PO2: 69 , HCO3: 21 , PAFI : 230, SAT: 91%, LAC 1.5 , BE : -4.2, HB : 15 // ACIDOSIS METABOLICA CON DSIFUNCION PULMONAR SEVERA SIN HIPERLACTATEMIA**.**
11/09/2025 GASES ARTERIALES PH: 7.32 , PCO2: 39, PO2: 76.8 , HCO3: 20 , PAFI : 219, SAT: 94%, LAC ,1.7 , BE : - 4.8, HB : 15 // ACIDOSIS METABOLICA CON DSIFUNCION PULMONAR SEVERA SIN HIPERLACTATEMIA.

CABERGOLINA 0.25 MG 2 TABLETAS DOSIS ÚNICA—-- SUSPENDIÓ NAPROXENO Y CISATRACURIOa- - FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS

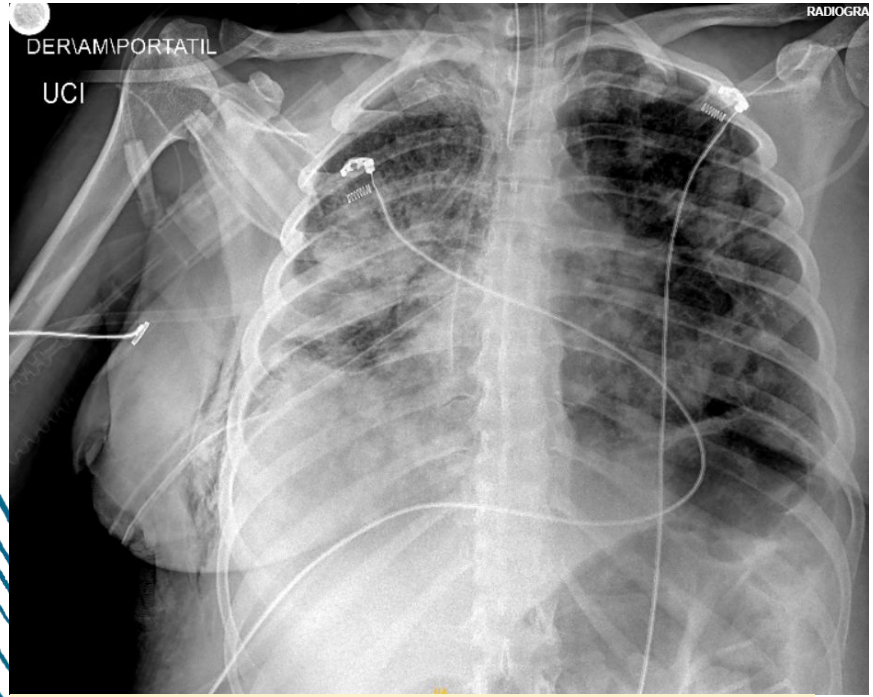
BALANCE HÍDRICO 12 HORAS
- ADMINISTRADOS: 5321.6 CC
- ELIMINADOS: 2100 CC
- GASTO URINARIO: 1.0 CC/KG/HORA
- BALANCE: (+) 3221.6 CC
- ACUMULADO: (+) 7.023.6 CC

11/09/2025 PT 10.3/9.7, **INR** DE 0.95, **PTT** 26.2/28.5, **BUN** 39, **CREATININA** 1.29, **SODIO** 139.7, **POTASIO** DE 4.83, **CLORO** 107.4, **HEMOGRAMA** LEUCOCITOS DE 19.6600, NEUTROFILOS DE 92.6, LINFOCITOS 4.0, HB DE 15.4 HTC DE 47.2PLQ DE 122.000

HIPERTERMIAS

*JESSICA LIZETH TORRES HOSPITALIZADA A CAUSA DE DISTRES RESPIRATORIO SEVERO DEL ADULTO
*GESTACIÓN DE 31 SEMANAS Y POR AUSENCIA DE BIENESTAR FETAL SE REALIZA UNA CESAREA DE EMERGENCIA
*RECIBIO DOS CICLOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA EN DECÚBITO PRONO
*HOY SE REALIZA EL PASO A VENTILACIÓN EN SUPINO LUEGO DE 2 HORAS CON CONTROL GASOMÉTRICO EN EL CUAL SE EVIDENCIA EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS VALORES DE FUNCIÓN PULMONAR
* DOSIS ESTABLES DE NOREPINEFRINA LAS CUALES NO HAN CAMBIADO EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
*PACIENTE NO ES CANDIDATA A VOLUMEN, PRESENTA UNOS BALANCES POSITIVOS SIGNIFICATIVOS POR LO CUAL SE INICIAN DIURÉTICOS DE ASA PARA MANTENER UN GASTO URINARIO ADECUADO
*PRESENTADO EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS REGISTROS FEBRILES
*RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS DISMINUYE EN EL LABORATORIO APARENTANDO UN FENÓMENO INFLAMATORIO HIPERREACTIVO CON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON PARACETAMOL Y AINES, CORTICOIDES Y MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS DE ENFRIAMIENTO EXTERNO PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO

PARACLINICOS DE CONTROL 11/09/2025



Opacidades mixtas difusas en ambos hemitórax.. Obliteración del seno costofrénico izquierdo. Tubo orotraqueal localizado a 42 mm de la carina. Catéter venoso central de acceso yugular izquierdo con extremo distal en topografía la aurícula derecha. Tubo de toracostomía con extremo distal proyectado parahiliar derecho. Elementos de monitoria externa. Enfisema paracostal derecho.

Nitrogeno Ureico - BUN 49.9 mg/dl 7.5- 22.5
CREATININA 1.30 mg/dl 0.6 1.1
SODIO SERICO 142.9 mmol/l 135 148
POTASIO SERICO 5.02 mmol/l 3.5- 5.1
CLORO EN SANGRE 107.8 mmol/l 98 110
MAGNESIO 3.0 mg/dl 1.6- 2.5
HEMOGRAMA LEU 21.94 NEU 96.0 LINF 2.4 HB 16.1 HCTO 49.3 PLT 93.0000 RMP 85.000

16+29 PH 7.28 PCO2 48 PO2 65 HCO3 23 PAFI 185 LAC 1.6 BE -3.9 ACIDOSIS RESPIRATORIA, DISFUNCIÓN PULMONAR MODERADA, SIN TRASTORNO DE PERFUSIÓN

11/09/2025 GASES VENOSOS PH: 7.21 , PCO2: 64, PO2: 40 , HCO3: 26 , SAT: 63%, LAC 1.5 , BE : -1.7, HB : 15 // T. EXTRACCIÓN DE 29 DELTA DE CO2 EN 16

EVOLUCIÓN TARDE 11/09/2025 (18+00 PM)

11/09/2025 GASES VENOSOS PH: 7.21 , PCO2: 64, PO2: 40 , HCO3: 26 , SAT: 63%, LAC 1.5 , BE : -1.7, HB : 15 // T. EXTRACCION DE 29 DELTA DE CO2 EN 16
11/09/2025 GASES ARTERIALES PH: 7.28 , PCO2: 48, PO2: 65 , HCO3: 23 , PAFI : 185, SAT: 89%, LAC 1.6 , BE : -3.9, HB : 15 // ACIDOSIS METABOLICA CON DSIFUNCION PULMONAR SEVERA SIN HIPERLACTATEMIA.
11/09/2025 GASES ARTERIALES PH: 7.32 , PCO2: 41, PO2: 70 , HCO3: 21 , PAFI : 200, SAT: 92%, LAC 1.6 , BE : -4.5, HB : 15 // ACIDOSIS METABOLICA CON DSIFUNCION PULMONAR SEVERA SIN HIPERLACTATEMIA.
11/09/2025 GASES ARTERIALES PH: 7.29 , PCO2: 43, PO2: 69 , HCO3: 21 , PAFI : 230, SAT: 91%, LAC 1.5 , BE : -4.2, HB : 15 // ACIDOSIS METABOLICA CON DSIFUNCION PULMONAR SEVERA SIN HIPERLACTATEMIA**.**
11/09/2025 GASES ARTERIALES PH: 7.32 , PCO2: 39, PO2: 76.8 , HCO3: 20 , PAFI : 219, SAT: 94%, LAC ,1.7 , BE : -

- EVOLUCIÓN LUEGO DEL PASE DE LA VENTILACIÓN EN DECÚBITO PRONO A VENTILACIÓN EN SUPINO INICIALMENTE FUE SATISFACTORIA DURANTE LA TARDE DE HOY
- PRESENTA UN DETERIORO IMPORTANTE DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIÓN PULMONAR MEDIO POR GASES
- TERCER CICLO DE VENTILACIÓN EN PRONO EL CUAL SE MANTENDRÁ DURANTE LAS PRÓXIMAS 24 HORAS

BALANCE HÍDRICO 24 HORAS
ADMINISTRADOS: 5321.6 CC -
ELIMINADOS: 2100 CC - GASTO URINARIO: 1.0 CC/KG/HORA -
BALANCE: (+) 3221.6 CC -
ACUMULADO: (+) 7.023.6 CC

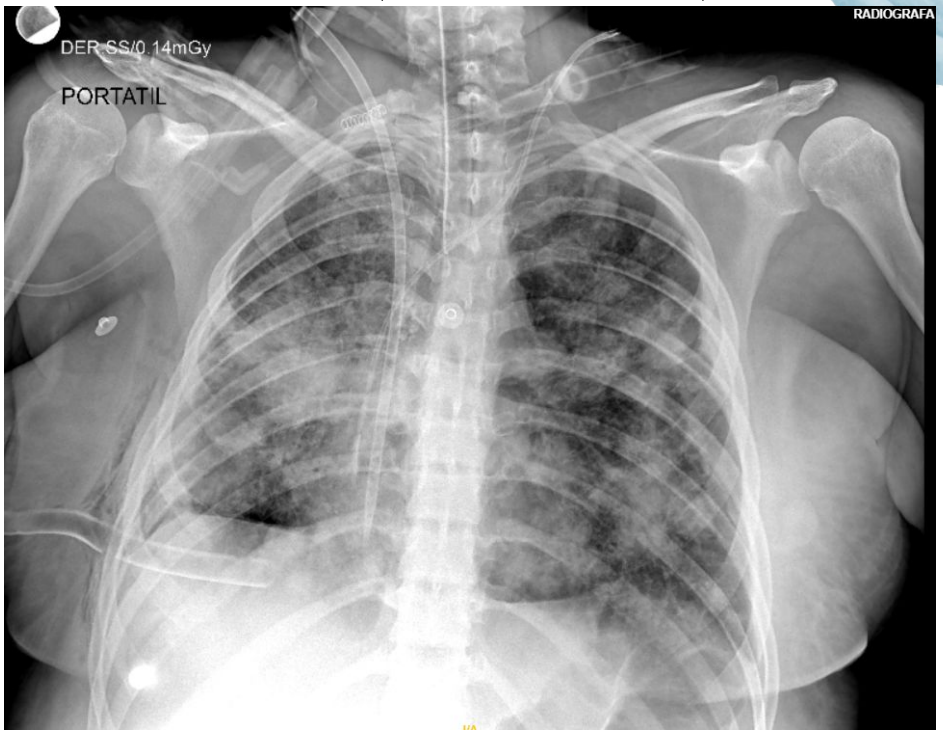
- VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA
- NUTRICIÓN ENTERAL CON ENSUR , 50 CC HORA META A DEFINIR
- PROPOFOL INFUSION CONTINUA TITULABLE DE 1 - 4 MG/KG/HORA BIS 30-40
- FENTANILO INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 1-3 MCG/KG/HORA BIS 30-40
- NOREPINEFRINA INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 0.05 -2.0 MCG/KG/MIN
- HIDROCORTISONA INFUSIÓN CONTINUA DE 200 MG IV PARA 24 HORAS
- CEFEPIME 2 GR IV CADA 8 HORAS FI: 08/09/2025
- CLARITROMICINA 500MG ORAL CADA 12 HORAS FI: 08/09/2025
- OMEPRAZOL 40 MG IV CADA DIA
- ENOXAPARINA 40MG SC CADA DIA
- DIPIRONA 2 GR CADA 8 HORAS - BISACODILO 5 MG VÍA ENTERAL CADA 12 HORAS
- PARACETAMOL 1 GR IV CADA 8 HORAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
- CARBOXIMETILCELULOSA 1 GOTA CADA 4 HORAS
- SALBUTAMOL 15 PUFF CADA 6 HORAS - BROMURO DE IPRATROPIO 15 PUFF CADA 8 HORAS

EVOLUCIÓN NOCHE 11/09/2025 (23+00 PM)

- FIEBRE INTRATABLE

- FIEBRE NO CONTROLADA A PESAR DE MANEJO CON ANTIPIRÉTICOS, MEDIOS FÍSICOS Y LÍQUIDOS FRÍOS
- ESQUEMA ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO CON CEFEPIME Y CLARITROMICINA DESDE EL 08/09/2025.
- PARACLÍNICOS MUESTRAN LEUCOCITOSIS PERSISTENTE CON NEUTROFILIA MARCADA, TROMBOCITOPENIA PROGRESIVA (93.000 – 122.000
- PROTEÍNA C REACTIVA Y FERRITINA MARCADAMENTE ELEVADAS, DÍMERO D AUMENTADO, LO QUE SUGIERE UN ESTADO INFLAMATORIO SISTÉMICO SEVERO CON DISFUNCIÓN MULTIORGÁNICA INCIPIENTE.
- SUMA INJURIA RENAL AGUDA ESTADIO AKIN I (CREATININA ESTABLE 1.29–1.3, BUN 31–49),
- ACIDOSIS METABÓLICA CON COMPENSACIÓN PARCIAL, SIN HIPERLACTATEMIA SIGNIFICATIVA, PERO EN RELACIÓN CON DISFUNCIÓN PULMONAR GRAVE.
- CANDIDATA A ESTRATEGIAS DE SOPORTE EXTRACORPÓREO RENAL MEDIANTE HEMODIAFILTRACIÓN, NO SOLO COMO MEDIDA DEPURATIVA, SINO TAMBIÉN COMO TERAPIA DE CONTROL DE LA TORMENTA INFLAMATORIA, CON EL FIN DE MODULAR LA RESPUESTA SISTÉMICA.

AUMENTO DE SOPORTE VASOPRESOR



Opacidades mixtas difusas en ambos hemitórax. Obliteración de los senos costofrénicos de forma bilateral. Tubo orotraqueal localizado a 44 mm de la carina. Catéter venoso central de acceso yugular izquierdo con extremo distal en topografía la aurícula derecha. Tubo de toracostomía con extremo distal proyectado parahiliar derecho. Elementos de monitoria externa. Enfisema subcutáneo paracostal derecho.

NOTA RETROSPECTIVA 12/09/2025 (4+30 AM)

PACIENTE MOTEADA BAJO VENTILACIÓN MECÁNICA EN PRONO.
RUIDOS RESPIRATORIOS HIPOVENTILACIÓN GLOBAL LLENADO CAPILAR LENTO

- PH 7.14 HCO3 DE 17.7 POTASIO 7.0 POR GASES SERICO 5.5, SE INDICA GLUCONATO DE CALCIO DADO TAQUICARDIA DE COMPLEJO ANCHO INTERPRETADA COMO TAQUICARDIA VENTRICULAR MONOMÓRFICA EN PACIENTE MULTI SOPORTADA SE CONSIDERA MANEJO CON CARDIOVERSIÓN ELECTRICA
- PERSISTE MOTEADA SE HA REALIZADO HASTA EL MOMENTO INICIO DE UN TERCER VASOPRESOR
- SE INICIA ALBUMINA DADO ESTADO DE CHOQUE, EN EL MOMENTO EN PRONO POR LO CUAL SE SUPINA PARA CARDIOVERSIÓN SE DISMINUYE SEDACIÓN.
- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EMBOLIA PULMONAR MIOCARDITIS POR SEPSIS

- MUY MAL ESTADO GENERAL DURANTE LA NOCHE CON FIEBRE INTRATABLE SE ADMINISTRÓ DIPIRONA, PARACETAMOL, LIQUIDOS FRIOS PERIFERICOS, CON POR SONDA OROGÁSTRICA POR SONDA VESICAL CON MEDIOS FISICOS DE FORMA PERIFÉRICA CON TEMPERATURA DE 40.6 GRADOS
- CON MEDIADORES INFLAMATORIOS ELEVADOS FERRITINA PCR DIMERO D, CONSIDERANDO PACIENTE CON FIEBRE INTRATABLE Y QUE ESTA ESTE GENERANDO LA TAQUICARDIA Y TODA LA CASCADA INFLAMATORIA PRESENTADA ESTE LLEVANDO A CHOQUE
- HEMODIAFILTRACION URGENTE SE REALIZA AJUSTE DE PARAMETROS POR PARTE DE NEFROLOGIA PARA UNICAMENTE REALIZAR LA DIALISIS Y NO ULTRAFILTRAR
- VASOPRESOR A DOSIS ALTA
- HIPOXEMIA CON FIEBRE PERSISTENTE, CON CHOQUE REFRACTARIO, SIN DISPONIBILIDAD DE VASOPRESINA COMO SEGUNDO VASOPRESOR POR DESABASTECIMIENTO NACIONAL
- ALTO RIESGO DE MORTALIDAD A CORTO PLAZO, SE CONSIGUE UNA UNICA AMPOLLA DE VASOPRESINA EN LA INSTITUCIÓN CV SE INICIA 4 UNIDADES HORA
- BRONCOESPASMO POR LO CUAL SE INDICA BETA 2 INHALADO TIENE INFUSIÓN DE ESTEROIDE Y SE INICIA ADMINISTRACIÓN DE SULFATO DE MAGNESIO 2 GR EN PRO DE MEJORAR EL BRONCOESPASMO
- EPINEFRINA
- SUSPENDEN DIÁLISIS DADO ESTADO DE CHOQUE REFRACTARIO
- DESCENSO DE TEMPERATURA 38.2 GRADOS
- SE INICIÓ UN TERCER VASOPRESOR MEJORANDO PRESIÓN ARTERIAL

NOTA RETROSPECTIVA 12/09/2025 (5+00 AM)

PACIENTE CON TAQUICARDIA DE COMPLEJO ANCHO INESTABLE DADO MULTIPLES VASOPRESORES, SE PROCEDE A REALIZAR CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA CON MEJORIA DE TAQUICARDIA Y DE COMPLEJO ESTRECHO AHORA, SE SUSPENDIÓ LA EPINEFRINA EN PRO DE MEJORAR TAQUICARDIA SIN EMBARGO DE NUEVO PRESENTA HIPOTENSIÓN RAZÓN POR LA CUAL SE INICIA INFUSIÓN A LA MITAD DE LA DOSIS INICIAL, PACIENTE CON LABILIDAD HEMODINÁMICA SEVERA TRI SOPORTADA, SE SUSPENDIO HEMODIALISIS, CONTINUA MOTEADA ACIDEMIA RESPIRATORIA REFRACTARIA SE INDICA REMISION ECMO VENOARTERIAL.



NOTA RETROSPECTIVA 12/09/2025 (7+00 AM)

NOREPINEFRINA
ADRENALINA
VASOPRESINA

- PACIENTE MOTEADA BAJO VENTILACION MECANICA EN PRONO.
- RUIDOS RESPIRATORIOS HIPOVENTILACION GLOBAL LLENADO
- CAPILAR LENTO MOTEDO GENERALIZADO

12/09/2025 12/09/2024 LEUCOS : 24.39 NEU : 93.5 LINF : 2.7 HG : 15.7 HCTO: 49.2 PLA : 76. 000 PLAQUETAS MANUAL : 72.000 CR: 1.42 BUN : 62.5 NA : 143 K : 5.56 CL : 107 MG : 3.2 CA: 1.22 TSH : 0.06 T4L: 1.02

-GASES ARTERIALES 04+15 AM: PH 7.14 PCO2 50.8 PO2 76.3 HCO3 17.7 BE -11.4 PAFI 76.3
GASES ARTERIALES 06+50 AM PH 6.90 CO2 40.5 PO2 112.6 LACTATO 7.7 PAFI 112 BASE EXCESO -24.8

SE REALIZA ORDEN DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE AEREO YA QUE POR INESTABILIDAD DE LA PACIENTE REQUIERE TRASLADO URGENTE

- GESTANTE QUE HA SIDO DESEMBRAZADA HACE 3 DÍAS,
- CHOQUE REFRACTARIO
- EVOLUCIÓN CLÍNICA EXTREMADAMENTE COMPLEJA, HIPOXEMIA REFRACTARIA, FIEBRE INTRATABLE, TAQUICARDIA, DISFUNCIÓN MULTIORGÁNICA Y RESPUESTA
- PACIENTE PRESENTÓ FIEBRE INTRATABLE (TEMPERATURA DE 40.6°C), A PESAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE ANTIPIRÉTICOS COMO DIPIRONA Y PARACETAMOL, ASÍ COMO LÍQUIDOS FRÍOS PERIFÉRICOS.
- LOS MEDIADORES INFLAMATORIOS COMO FERRITINA, PCR Y DÍMERO D SE ENCUENTRAN ELEVADOS, LO QUE RESPALDA LA PRESENCIA DE UNA INFLAMACIÓN SISTÉMICA SEVERA.
- ADRENALINA, NORADRENALINA Y VASOPRESINA Y AHORA ÚLTIMO AZUL DE METILENO, CON RESPUESTA INADECUADA, LO QUE REFLEJA UN GRAVE DETERIORO DE LA FUNCIÓN CARDIOVASCULAR.
- TRES CICLOS REALIZADOS DADO EL TRASTORNO SEVERO DE LA OXIGENACION, SIN RESULTADOS SIGNIFICATIVOS EN LA MEJORA DE LA OXIGENACIÓN, LO QUE INDICA UNA HIPOXEMIA REFRACTARIA SECUNDARIO A SU SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO (SDRA)
- BRONCOESPASMO, LO QUE HA SIDO MANEJADO CON INHALACIONES DE BETA-2 AGONISTAS, JUNTO CON LA ADMINISTRACIÓN DE ESTEROIDES Y SULFATO DE MAGNESIO PARA INTENTAR MEJORAR LA FUNCIÓN RESPIRATORIA.
- CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA, PARA INTENTAR RESTABLECER EL RITMO CARDIACO NORMAL
- HEMODIAFILTRACIÓN URGENTE PARA TRATAR DE CONTROLAR EL ESTADO DE HIPERPOTASEMIA Y ACIDOSIS METABÓLICA GRAVE, DADA LA SITUACIÓN DE CHOQUE REFRACTARIO Y LA INESTABILIDAD HEMODINÁMICA, SE SUSPENDIÓ LA DIÁLISIS Y SE PRIORIZÓ EL MANEJO DE LA PRESIÓN ARTERIAL MEDIANTE EL AJUSTE DE VASOPRESORES, CON LA INCLUSIÓN DE UN TERCER VASOPRESOR PARA MEJORAR LA PERFUSIÓN SISTÉMICA AZUL DE METILENO
- DISFUNCIÓN MULTIORGÁNICA PROGRESIVA Y COMPLICACIONES ARRÍTMICAS

EVOLUCIÓN DIA 12/09/2025 (2+00 PM)

PACIENTE FEMENINA DE 27 AÑOS CON DIAGNÓSTICOS DE:
- CHOQUE REFRACTARIO
-SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO SEVERO DEL ADULTO
- NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD PSI SCORE Clase V (riesgo alto)
- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA - POP TORACOSTOMÍA CERRADA DERECHA 09/09/2025
- NEUMOTÓRAX DERECHO
- POSTOPERATORIO CESÁREA 08/09/2025 G2C1P1V2
- RECIÉN NACIDO MASCULINO APGAR 3-4-8
- PUERPERIO MEDIATO - INJURIA RENAL AGUDA AKIN I
- INJURIA MIOCÁRDICA ASOCIADA A LA SEPSIS
- ASMA PERSISTENTE MODERADA/GRAVE
- CRISIS ASMATICA SEVERA
- RIESGO OBSTÉTRICO ALTO MADRE CON DIAGNÓSTICO DE THAE RIESGO ISOINMUNIZAIÓN RH NEGATIVO
RIESGO TROMBOEMBOLICO BAJO RIESGO PSICOSOCIAL: BAJO ESCALA HERRERA Y HURTADO DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL: SOBREPESO PARA EDAD GESTACINOAL ATHALA IMC 30

BALANCE HÍDRICO 24 HORAS
ADMINISTRADOS: 5321 CC
- ELIMINADOS: 2100 CC
GASTO URINARIO: 1.0 CC/KG/HORA
BALANCE: (+) 3321 CC

12/09/2025 LEUCOS **:** 24.39 NEU : 93.5 LINF : 2.7 HG : 15.7 HCTO: 49.2 PLA : 76. 000 PLAQUETAS MANUAL : 72.000 CR: 1.42 BUN : 62.5 NA : 143 K : 5.56 CL : 107 MG : 3.2 CA: 1.22 TSH : 0.06 T4L: 1.02 POTASIO 7.0 MAGNESIO 3.9 CALCIO 7.8

12/09/2025 TAQUICARDIA REGULAR DE COMPLEJO ANCHO
NOREPINEFRINA INFUSIÓN CONTINUA TITULABLE 0.05 -2.0 MCG/KG/MIN

12/09/2025GASES ARTERIALES HORA 10+00 PH 6.7 PCO2 51.4 PO2 95 HCO3 6.4 LACTATO 12.7 PAFI 95 SATURACION 82% 12/09/2025 GASES ARTERIALES

04+15 AM: PH 7.14 PCO2 50.8 PO2 76.3 HCO3 17.7 BE -11.4 PAFI 76.3 GASES ARTERIALES 06+50 AM PH 6.90 CO2 40.5 PO2 112.6 LACTATO 7.7 PAFI 112 BASE EXCESO -24.8

EVOLUCIÓN DIA 12/09/2025 (2+00 PM)

JESSIKA PACIENTE EN CUIDADO INTENSIVO DESDE EL 08/09/2025 EN CONTEXTO DE UNA CRISIS ASMATICA SEVERA CON NECESIDAD DE VENTILACION MECANICA CON CRITERIOS PARA SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO AGUDO CON TRANSTORNO SEVERO DE LA OXIGENACION QUIEN EN LAS ULTIMAS 24 HORAS HA PRESENTADO UN DETERIORO DE SU ESTADO SEVERO AL PUNTO DE REQUERIR TRES MEDICAMENTOS DIFERENTES VASOPRESORES EN LAS ULTIMAS 8 HORAS CON NECESIDAD DE BOLOS DE BICARBONATO EN ARAS DE MEJORAR ACIDEMIA Y ASI MEJORAR LA ACTUACION DE LOS VASOPRESORES, SE USO TIAMINA, TERLIPRESINA DADO NO DISPONIBILIDAD DE VASOPRESINA COMO MANEJO DEL CHOQUE REFRACTARIO, DURANTE LA MAÑANA DURANTE VARIAS OCASIONES PRESENTO TENSION ARTERIAL SISTOLICA POR DEBAJO DE 70 MMHG QUE MEJORARON INICIALMENTE CON BOLO DE AZUL DE METILENO PERO NO CON INFUSION CONTINUA, CON BOLO DE BICARBONATO PERO NO CON LA INFUSION DE BICARBONATO, DE DIAGNOSTICOS DE TRABAJO SE PLANTEO UN SDRA SECUNDARIO A INFECCION VIRAL CON POSTERIOR COMPROMISO MULTIORGANICO Y CHOQUE SEPTICO REFRACTARIO Y ESTABAMOS A LA ESPERA DE AISLAMIENTOS POR HEMOCULTIVOS LOS CUALES HASTA EL MOMENTO VAN NEGATIVOS, EN PROCURA DE MEJORAR PARAMETROS DE CHOQUE SE SUSPENDIO PROPOFOL SIN RESPUESTA A ESTA MANIOBRA CON UN EMPEORAMIENTO GASIMETRICO SEVERO EN LOS GASES ARTERIALES CONTROL DE LA MAÑANA 10 AM PH 6.7 HCO3 6 LACTATO DE 12, ADEMAS PACIENTE ANURICA Y CON EMPEORAMIENTO DEL MOTEADO, CONSIDERANDO CURSA CON UN CHOQUE REFRACTARIO Y PROBABLEMENTE EN FASE NO REVERSIBLE SE INDICA SUPINAR LA PACIENTE PREVINIENDO UNA PARADA CARDIACA EN PRONO ALREDEDOR DE LAS 09+00 AM, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA SE REALIZA COMUNICACION CON EPS COOSALUD CRUEB BOYACA Y SE ENVIA FORMATO DE REMISION A ESTAS ENTIDADES SOLICITANDO TERAPIA ECMO, DURANTE LA NOCHE SE PLANTEARON CRITERIOS PARA ECMO QUE NO CUMPLIA LA PACIENTE PARA ESTA TERAPIA NO TENIA UNA PAFI MENOR DE 80 NO EL PH ERA DE 7.25 SIN EMBARGO EL CO2 DE 56, COMO CONSTATA EN ANTERIORES EVOLUCIONES SE REALIZO INICIO DE HEMODIAFILTRACION EN PRO DE BARRER MEDIADORES INFLAMATORIOS Y LOGRAR DISMINUIR LA RESPUESTA SISTEMICA Y LA FIEBRE INTRATABLE, SIN EMBARGO CON NECESIDAD DE AUMENTAR EL SOPORTE SE DECIDIÓ SUSPENDER DICHA TERAPIA Y DURANTE LA EVOLUCION

EL CHOQUE REFRACTARIO INICIA A LAS 05+20 AM DONDE SE INICIA ADRENALINA Y VASOPRESINA UNICA AMPOLLA DISPONIBLE POR DESABASTECIMIENTO NACIONAL DE DICHO MEDICAMENTO SE PLANTEO LA NECESIDAD DE ECMO SOLICITUD QUE QUEDO RADICADA EN LA MAÑANA CON GRAN AYUDA DE EPS COOSALUD QUIEN NOS ENVIO DOS ACEPTACIONES DE LA PACIENTE INICIALMENTE FUNDACION CARDIO INFANTIL QUE NO PODIA REALIZAR EL TRASLADO PARA CANULAR LA PACIENTE Y CLINICA SAN LUIS BUCARAMANGA QUE TENIA EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS LISTOS PARA TRASLADO SIN EMBARGO POR UBICACION GEOGRAFICA NO EXISTIA UNA PISTA ADECUADA CERCANA A NUESTRO HOSPITAL PARA REALIZAR CANULACION Y POSTERIOR TRASLADO, INFORMACION SUMINISTRADA POR GESTORA PARA BOYACA DE EPS COOSALUD CONTINUANDO CON EL ESTADO DE LA PACIENTE JESSIKA YA HABIA TENIDO ESTUDIOS DE DERRAME PLEURAL EN PRO DE DESCARTAR EMPIEMA NEGATIVO PARA ESTA POSIBILIDAD EL ESTUDIO DEL LIQUIDO PLEURAL, HABIA TENIDO ESTUDIOS DE INFECCION DE VIAS URINARIAS, TORMENTA TIROIDEA ENTRE OTRAS PATOLOGIAS QUE FAVORECIERAN EL ESTADO INFLAMATORIO SIN

EVOLUCIÓN DIA 12/09/2025 (2+00 PM)

EMBARGO DICHAS PATOLOGÍAS FUERON DESCARTADAS, LA EVOLUCION RADIOGRAFICA Y LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS NOS HIZO PENSAR SIEMPRE EN UN SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO AGUDO CON TRANSTORNO SEVERO DE LA OXIGENACIÓN FAVORECIDO POR SU ESTADO ASMATICO SIENDO LAS 11+00 AM PACIENTE PRESENTA TAQUICARDIA DE COMPLEJO ESTRECHO SUPRAVENTRICULAR EN UNA PACIENTE INESTABLE REQUIRIENDO DE CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA CON 80 JULS MEJORANDO LA TAQUICARDIA, SIENDO LAS 12+31 PM Y TRAS UN CHOQUE REFRACTARIO UNA VASOPLEJIA SEVERA UN DISTRESS RESPIRATORIO SEVERO REFRACTARIO CON INFUSIÓN DE NOREPINEFRINA A 2 MCG KG MIN 1.5 MCG KG MIN Y AZUL DE METILENO A 2 MG K HORA LA PACIENTE PRESENTA UNA PARADA CARDIACA RITMO DE PARO ACTIVIDAD ELECTRICA SIN PULSO SE INICIAN MANIOBRAS DE REANIMACIÓN AVANZADA COMPRESIONES VENTILACIONES SE REALIZA CORRECCION DE HIPERKALEMIA Y HIPERMAGNESEMIA CON GLUCONATO DE CALCIO, ADMINISTRACION DE ADRENALINA CADA 3 MINUTOS SEGUN PROTOCOLO AHA CON COMPROBACION DE RITMO Y PULSO CADA DOS MINUTOS PERSISTIENDO DURANTE 21 MINUTOS EN ASISTOLIA, SE ADMINISTRAN 8 AMPOLLAS DE EPINEFRINA DURANTE LA REANIMACIÓN Y TRAS 21 MINUTOS DE PARADA CARDIACA EN RITMO DE ASISTOLIA Y NO OBTENER RETORNO A CIRCULACIÓN ESPONTÁNEA SE PARAN ESFUERZOS DE REANIMACIÓN Y SE DECLARA FALLECIDO

12+52 PM SE REALIZA INFORMACIÓN A LA FAMILIA DEL DESENLACE FATAL SE LES PRESTA ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO SE PERMITE DESCARGA EMOCIONAL E INGRESAN FAMILIARES A CUBÍCULO DE UCI, POR PARTE DE SECRETARIA DE SALUD SUGIEREN REALIZAR NECROPSIA CLÍNICA DADO QUE ES UN EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA Y AL SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA FAMILIA MADRE Y ESPOSO DE LA PACIENTE NO AUTORIZAN REALIZACIÓN DE LA MISMA POR LO CUAL SE PROCEDE A CERRAR HISTORIA CLÍNICA REALIZAR CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN Y EPICRISIS

GRACIAS

